

國立臺北護理健康大學護理系
碩士論文
School of Nursing
National Taipei University of Nursing and Health Sciences
Master Thesis

以德菲法建構中西醫居家照護模式
Development of A Home Care Model for Collaboration
Between Traditional Chinese and Western Medicine Systems: A
Delphi Method

張瑋芬
Wei-Fen Chang

指導教授：江慧珠 博士
Advisor: Hui-Chu Chiang, Ph.D.

中華民國 114 年 8 月
August, 2025

國立臺北護理健康大學碩士學位考試委員會審定書

本校 護理 系（所） 張瑋芬 君

所提論文 以德菲法建構中西醫居家照護模式

經本委員會審查合格並口試通過，特此證明。

學位考試委員會委員：

何象融

江慧玲

陳建新

指導教授：

江慧玲

系主任（所長）：

林伯平

學位考試日期：中華民國 114 年 7 月 24 日

誌 謝

誠摯感謝口試委員何宗融教授與陳建和教授，於百忙之中撥冗審閱，並提供寶貴意見，使本研究能夠更加完善與周延。也感謝研究所所有老師在求學歷程中的教導，讓我累積了豐富的知識基礎與研究養分。

此外，特別感謝台北慈濟醫院黃如婕同學，在研究收案過程中給予我許多支持與協助；同時也要衷心感謝中西醫護理碩士班的同學們，彼此在課業與研究上的陪伴與鼓勵，讓我在學習旅程中不再孤單。身為班上幸福的小妹，能得到大家無私的照顧與提攜，是我最大的幸運與感恩；也要感謝工作上的同事們，在我同時兼顧學業與工作的期間，願意體諒與配合，使我能安心投入研究。

最後，深深感謝一路支持我的家人與親友，是你們的鼓勵與陪伴，成為我前進的最大動力。特別是在每次下課後，從台北趕返花蓮的路途中，不論多晚，總有人在火車站等候並接送我，這份默默的守候與支持，使我能無後顧之憂地專注於學業與研究，亦是我能堅持完成此篇論文的重要力量。

「只要方向正確，腳步就不怕慢；堅持下去，就能到達目的地。」—證嚴上人。這句話正是我完成此篇論文的真實寫照。

張瑋芬 謹誌于

2025 年 8 月

中文摘要

研究背景：面對日益複雜的病人疾病，跨領域團隊合作照護成為醫學照護品質中相當重要的課題。中西醫居家照護已施行多年，跨領域合作的流程及模式尚未有明確的流程，使不同專業間在角色分工、溝通協調與照護目標上的整合機制有落差。

研究目的：(1)探討中西醫居家照護應包含的職類、工作內容、照護職責及角色(2)探討各職類於中西醫居家照護合作的關係。(3)探討「中西醫居家照護模式」之要素。

研究方法：本研究採用修正式德菲法，邀請 24 位具中西醫居家照護及跨專業合作經驗之專家，進行三回合問卷調查。專家群涵蓋護理師、西醫師、中醫師、藥師、營養師、社工師、復健師與呼吸治療師等八大職類。研究透過百分比與 Fleiss' Kappa 統計分析專家意見一致性與穩定度，以評估共識的情形。

研究結果：自 2024 年 4 月至 2025 年 6 月，經三回合問卷調查與意見整合後，建構出五大部分「居家訪視與收案紀錄」、「持續照護與健康追蹤」、「執行療護與紀錄」、「其他職類參與」及「跨領域團隊合作」之共識。繪製出「中西醫居家照護流程圖」，並將參與職類分為「第一層核心職類」（西醫師、中醫師、護理師）與「第二層多元職類」（藥師、營養師、社工師、復健師及呼吸治療師）。研究也確認了居家照護的職類對於資訊共享均達到高度共識。

結論：本研究探討出的中西醫居家照護模式裡的要素，可作為後續學術探討跨領域合作、居家照護模式發展與政策推動之參考。

關鍵字：跨領域團隊合作照護、中西醫、居家照護、德菲法

ABSTRACT

Background: As patient conditions become increasingly complex, interprofessional collaboration has emerged as a key strategy for improving the quality of care. Although home care services integrating Traditional Chinese Medicine (TCM) and Western Medicine (WM) have been implemented for several years, a clearly defined process and model of collaboration remain lacking. This absence of structure has created gaps in role delineation, communication, coordination, and the establishment of shared care goals across professions.

Purpose: (1) identify the professions, job duties, responsibilities, and roles that should be included in a home care model integrating Traditional Chinese and Western medicine; (2) examine the collaborative relationships among the various professions within this model; and (3) explore the key elements and develop a structured model for collaboration between Traditional Chinese and Western medicine systems.

Methods: A modified Delphi method was employed, involving 24 experts with experience in integrated home care combining TCM and WM as well as interprofessional collaboration. The panel comprised eight professional categories: nurses, WM physicians, TCM physicians, pharmacists, dietitians, social workers, rehabilitation therapists, and respiratory therapists. Three rounds of questionnaires were conducted, and data were analyzed using percentage and Fleiss' Kappa to evaluate the consistency and stability of expert consensus.

Results: Between April 2024 and June 2025, consensus was achieved after three survey rounds and the integration of expert opinions on five key components: Home Visits and Case Records, Continuous Care and Health Tracking, Treatment Implementation and Documentation, Involvement of Other Professions, and Interprofessional Collaboration. Based on these findings, a home care model integrating TCM and WM was developed,

categorizing professions into core professions (WM physicians, TCM physicians, and nurses) and supporting professions (pharmacists, dietitians, social workers, rehabilitation therapists, and respiratory therapists). A high level of consensus was also reached regarding the importance of information sharing across professions in home care.

Conclusion: The elements identified in the home care model integrating Traditional Chinese and Western medicine in this study provide a valuable reference for future academic research on interprofessional collaboration, the development of home care models, and related policy initiatives

Keywords: Interprofessional collaboration, Traditional Chinese and Western medicine, Home care, Delphi method

目 次

中文摘要	iii
英文摘要	iv
目 次	vi
表 次	viii
圖 次	ix
第一章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究動機	4
第四節 研究問題	8
第五節 名詞界定	8
第二章 文獻查證	10
第一節 跨領域團隊合作照護	10
第二節 居家照護	13
第三節 中醫與西醫	16
第四節 德菲法	17
第三章 研究方法	22
第一節 研究設計及工具	22
第二節 研究場所及研究對象	22
第三節 資料處理與分析	23
第四節 研究步驟	25
第五節 研究倫理考量	28
第四章 研究結果	29
第一節 專家組成	29
第二節 第一回合德菲法專家問卷研究結果	31
第三節 第二回合德菲法專家問卷研究結果	40
第四節 第三回合德菲法專家問卷研究結果	48
第五章 討論	54
第六章 結論、限制與建議	61
第一節 結論	61
第二節 限制與建議	61
參考文獻	63
中文部分	63
英文部分	66
附錄	69
附錄一 研究倫理委員會研究計畫許可書	69

附錄二 研究倫理委員會研究計畫變更許可書	70
附錄三 學位論文原創性比對檢核表	71
附錄四 原創性比對報告書	72

表 次

表 1-1 「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」各照護階段之給付項目	3
表 2-1 德菲法相關研究	21
表 3-1 描述性統計分析說明	23
表 3-2 Kappa 區間定義	24
表 4-1 專家成員基本資料(N=24).....	30
表 4-2 第 1 回合-第一部分評估 專家意見及統計結果(N=24)	32
表 4-3 第 1 回合-第二部分療護計畫與執行 專家意見及統計結果(N=24).....	34
表 4-4 第 1 回合-第二部分療護計畫與執行 專家意見及統計結果(N=24).....	35
表 4-5 第 1 回合-第三部分團隊合作專家意見及統計結果(N=24)	36
表 4-6 各職類於進行居家照護時需參閱的資料-第一部分(N=24)	37
表 4-7 各職類於進行居家照護時需參閱的資料-第二部分(N=24)	38
表 4-8 各職類於進行居家照護時需參閱的資料-第三部分(N=24)	39
表 4-9 第 2 回合專家意見及統計結果(N=24)	41
表 4-10 第 2 回合專家意見及統計結果(N=24).....	42
表 4-11 第 2 回合專家意見及統計結果(N=24).....	43
表 4-12 各職類需參閱資料的資料 (N=24)	46
表 4-13 各職類需參閱資料的資料(N=24)	47
表 4-14 第三回合專家共識結果(N=14).....	49
表 4-15 第三回合專家共識結果(N=14).....	50
表 4-16 各職類於參與居家照護需取得資料情形-	51
表 4-17 各職類於參與居家照護需取得資料情形-	52

圖 次

圖 1-1 目前居家照護的困境的說明.....	7
圖 2-1 The visualized interprofessional practice process	13
圖 3-1 研究階段流程圖	25
圖 4-1 中西醫居家照護流程圖	53

第一章 緒論

為探討中西醫居家照護模式裡的要素，統整現況作為本研究。本章分為四小節，依次為第一節研究背景、第二節研究動機、第三節研究目的、第四節研究問題、第五節名詞界定，詳述如下。

第一節 研究背景

一、居家照護的相關計畫

衛生福利部自 1993 年起推動「出院準備服務」，當個案急性醫療需求降低，但仍有功能缺損的情形時，可連結長期照護服務（如居家照護等），作為急性醫療及後續照顧的橋樑。

健保署（現衛生福利部）於 2015 年推出「居家醫療整合照護試辦計畫」，此計畫將個案的照護需求分為「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」三個階段，只提供醫事人員於各階段之服務項目(表 1-1)，其中「居家醫療」僅給付醫師訪視，沒有其他職類的給付、「重度居家醫療」及「安寧療護」給付醫師、護理人員、呼吸治療人員、其他專業人員訪視。這些計畫雖然提升了因失能或疾病特性，致外出就醫不便患者取得醫療照護的可近性，並未說明居家醫療照護實質的運作方式、專業人員的定義，以及醫事人員間如何進行溝通、互動及合作，才能提供整合性的照護。

同年，衛生福利部提供了「居家醫療整合照護資訊共享平台」（表 1-2）。內容包括：1.「個案基本資料」，除建立「基本資料」外，可將特殊事項輸入，提供照護成員參考；2.「照護計畫」部分，居家由主治醫師設定該病患需要達到的照護目標及訪視頻率；3.「訪視紀錄」部分，由居家照護人員，在訪視後登錄訪視期間的評估、生命徵象、照護內容等資料。4.「交流討論」：居家照護成員可在此留言給合作的醫療院所。

2019 年，衛福部修訂「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，將中醫師、牙醫師、藥師納入，同時「居家醫療」訪視給付新增牙醫師及中醫師項目；「重度居家醫療」及「安寧療護」訪視給付將牙醫師、中醫師及藥師納入（表 1-1）。中醫於 2019 年納入居家照護成員後，衛生福利部為建立當地常見病症之中醫社區（含預防醫學）、居家醫療照護及長期照顧服務模，於 2020 年起衛福部與中醫師公會推動「建立中醫社區及居家醫療服務網絡計畫」，規劃補助 6 分區，每區 185 至 210 萬元不等，補助預算總金額為 1,200 萬元/年，且要求各機構必須提供成效報告。縱使如此，跨中西醫體系之專業人員如何提供失能病人完整且連續性照護，仍是值得被探討的議題。

2020 年再修訂「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，沿用 2016 年的三照護階段，牙醫不再含括在內。從表 1-1 彙整「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」各照護階段之給付項目可見，提供居家照護的醫事人員職類增多，但計劃書內雖提供了各職類基本照護內容，但未有進一步的溝通、互動及合作，成員間如何進行合作提供病人完整的照護

從以上我國政府推展的居家醫療照護計畫，可以看出居家醫療照護應當是在跨領域團隊合作之下進行。要合作提供服務的醫療團隊日益複雜，涉及職類繁多，不僅是西醫體系內的不同專業間的合作，還包括中醫與西醫兩個不同醫療體系之間的合作。如此多元的團隊如何溝通及互動？迄今最新的計畫內容，仍未有具體的說明。2016 年，政府雖已建置「居家醫療整合照護資訊共享平台」，但各職類人員僅輸入自己的照護內容，未提供在臨床上遇到困境及問題時可以尋求誰的專業，若個案照護需求改變時，需重啟交流討論，待對方看見系統上的提問或是以電話連繫後，才能進行討論。

表 1-1

「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」各照護階段之給付項目

年份 照護階段	2016 年	2019 年	2020 年	2024 年
居家醫療	1.醫師訪視	1.醫師訪視 2.牙醫師訪視 3.中醫師訪視 4.藥師訪視	1.醫師訪視 2.中醫師訪視 3.藥師訪視	1.醫師訪視 2.中醫師訪視 3.藥師訪視
重度居家 醫療	1.醫師訪視 2.護理人員訪視 3.呼吸治療人員訪視 4.其他專業人員訪視	1.醫師訪視 2.牙醫師訪視 3.中醫師訪視 4.護理人員訪視 5.呼吸治療人員訪視 6.藥師訪視 7.其他專業人員訪視	1.醫師訪視 2.中醫師訪視 3.護理人員訪視 4.呼吸治療人員訪視 5.藥師訪視 6.其他專業人員訪視	1.醫師訪視 2.中醫師訪視 3.護理人員訪視 4.呼吸治療人員訪視 5.藥師訪視 6.其他專業人員訪視
安寧療護	1.醫師訪視 2.護理人員訪視 3.呼吸治療人員訪視 4.其他專業人員訪視	1.醫師訪視 2.牙醫師訪視 3.中醫師訪視 4.護理人員訪視 5.呼吸治療人員訪視 6.藥師訪視 7.其他專業人員訪視	1.醫師訪視 2.中醫師訪視 3.護理人員訪視 4.呼吸治療人員訪視 5.藥師訪視 6.其他專業人員訪視	1.醫師訪視 2.中醫師訪視 3.護理人員訪視 4.呼吸治療人員訪視 5.藥師訪視 6.其他專業人員訪視

註：取自衛生福利部 2016 年、2019 年、2020 年及 2024 年「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」；新增項目以「_____」標示

2013 年，衛福部「教學醫院評鑑基準及評量項目」中，將跨領域團隊合作照護實作內容納入，如醫療團隊資源管理(team resource management, TRM)、聯合照護案例討論會(combined conference)、共同照顧(combined care)、出院準備服務、團隊治療、安寧療護、病人安全等。

為了取得教學醫院評鑑通過，爭取健保給付款項，各地區醫院及醫學中心紛紛將跨領域團隊合作照護列為常規的一環。起初，此模式主要應用於加護病房及急診室，隨後逐步推廣至病房區，以提升整體醫療照護的合作效能。此外，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會於 2017 年的醫學中心評鑑基準及評量項目，將「依病情需求，適切照會相關之醫療照護團隊，各種領域間有良好的協調及溝通」列入第 2 篇，醫療照護中的第 2.3 章醫療照護之執行與評估之規範（醫策會，2017）。

綜合以上，多元專業人員如何提供失能病人完整且連續性照護，是值得被探討的議題。

第二節 研究動機

花蓮慈濟醫院是慈濟證嚴上人因臺灣東部地區醫療匱乏，1966 年於花蓮成立「佛教克難慈濟功德會」，開始慈善濟貧的工作。1986 年佛教慈濟綜合醫院於花蓮正式啟用。於 2002 年成為台灣東部唯一的醫學中心，負有訓練教學、領導之任務，以及急重症災難醫療照護之責(慈濟全球網，2021)。

研究者為花蓮慈濟醫院的護理師，目前同時為國立臺北護理健康大學的研究生。在實習期間，前往中醫居家照護實習，因而對中西醫居家照護產生興趣。

一、慈濟醫院的跨領域團隊照護

跨領域團隊合作照護成為現在的台灣教學醫院評鑑基準。值得注意的是，經過10餘年的推動，跨領域團隊合作照護仍沒有更好的合作互動，可能與缺乏跨領域團隊照護認知相關（李佳倫、洪志秀，2017）。而跨領域團隊合作照護為現今醫療照護的趨勢，為確保照護之連續與可及性，醫療照護提供者在執行醫療照護上，由醫策會(2008)提出「跨領域團隊合作照護」具備之四大要素-「4C」包含：

- (一) 建立共同目標(Common goals)。
- (二) 共享資訊與資源(Collaboration：Information and resource sharing)。
- (三) 協調活動及決策(Coordination of decision and activity)。
- (四) 團隊成員間的溝通（Communication among team members）。

配合教學醫院評鑑要求，自 2015 年起，開始辦理跨領域照護討論會，由重症單位外科加護病房於每個月定期舉辦「跨領域聯合討論會」，透過院內跨團隊照護電子系統，了解團隊間工作的狀況，再利用系統公告及電子信箱，邀請與個案健康問題相關的成員參與。以住院病房為例，住院中特殊案例，於每周依個案情況，由主治醫師邀請護理師、藥師、個管師等其他職類人員進行「跨團隊討論會」。經由住院醫師介紹個案，使用院內自行發展的跨團隊照護電子系統，說明目前治療目標及進度，護理師說明照護情形，藥師做藥物使用的提醒及建議，最後由主治醫師進行決策及總結。

而現今的醫療環境中，病人疾病複雜度日益增加，病人的問題多重，需要投入跨領域團隊的成員眾多，臨床照護上很難有時間放下手邊的照護工作進行團隊討論，因此在難以齊聚一堂進行討論的情況下，除了特殊案例之外，現在多以院內自行建構的電子系統進行溝通、協調及合作照護。由主治醫師依個案需求，邀請其他專業人員進行評估及診療，於 24 小時內進行系統上的初步的回覆，待完整評估後再進行具體回覆，可於跨領域團隊照護系統，即時查看個案跨團隊照護的情形，且能同時在系統上進行文字溝通與討論，與多團隊進行討論，其對話內容可於系統上呈現讓其他成員看到；另外會診其他科醫師的情形也可見個案目前照護的情形。透過這樣的討論，可以達到多專業互動的效果。

一、中醫與居家醫療

證嚴上人在創辦慈濟醫院的時候，即期望能以西方醫學為基礎，發揚中醫學。因而，在 1992 年開設了「中醫門診」；2013 年開辦「中西醫腫瘤聯合門診」。2016 年，為了讓會診中醫的住院病人擁有專用的診療間，成立「中西醫合作住院照護中心」。2020 年，於原有的神經內外科病房中，規劃專區設置「中西醫合療病房」；2020 年底，則建立了「中醫病房-自在居」（慈濟全球網，2021）。

於 2019 年 9 月配合前段提到的「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，中醫師開始加入居家照護團隊。起初由居家照護的西醫師評估個案有中醫治療需求，或由個案主動提出中醫治療，由中醫師評估後再由行政助理進行收案，每周 2-3 次由中醫主治醫師及一名中醫住院醫師前往居家提供診治，同時當個案有其他照護問題時，醫師會透過電話聯繫居家護理師完成個案的其他照護需求。

當居家護理人員被其他醫事人員告知個案的需求，或是護理師發現個案的健康問題後，仍需透過電話或當面聯繫主治西醫師，請他照會其他領域的專業人員，而居家護理師不知道甚麼樣的時機或條件下應該要尋求那些職類的協助，沒有既定的照護模式，而聯絡後病人獲得照護的情形無從得知。

研究生於中醫居家臨床實務中所見，由護理師擔任個管師一職，評估病人出院後的需求，協助病人與家屬做出院準備，銜接中醫或西醫居家照護。而居家照護師在中西醫居家照護的情境中，面臨許多兩難，顯現團隊溝通、聯繫、協調及合作上仍有諸多不足。例如：

「一個常自拔鼻胃管的伯伯，家屬在詢問關於鼻胃管的選擇時，當需要其他團隊協助時，該如何轉介，以及哪些團隊可以給予支援？」。

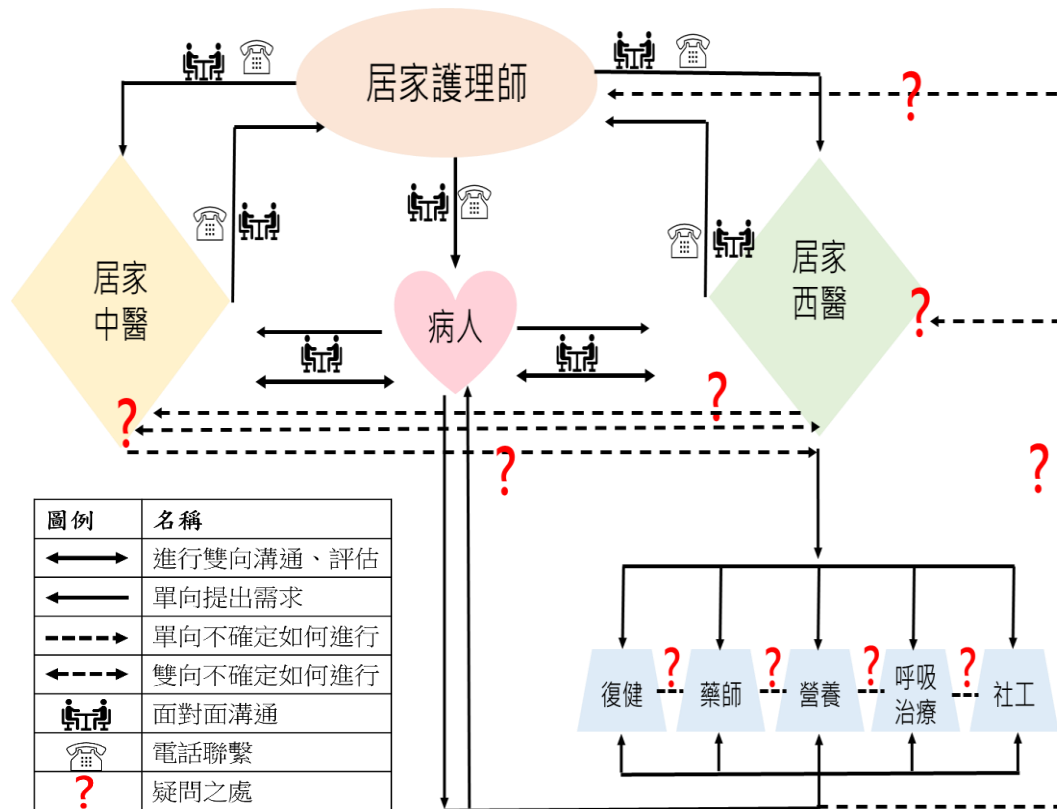
「家屬在詢問相關居家復健問題時，不清楚究竟聯絡的窗口在哪裡，只能在返回醫院後電話聯絡該區段的居家護理師協助聯繫」。

「管灌食病人營養品選擇問題時，一般飲食可由護理師進行衛教，但特殊飲食(例如全素病人的營養，該使用何種配方替代、碎食食物與管灌飲食的替換原則等)，此類問題該如何找窗口做諮詢或轉介」。

「中藥跟西藥會不會有重複治療的問題，西醫師知道我吃的中藥有通血路的配方，還是中醫師知道我西藥有再吃一些抗凝血劑嗎?我怕吃太多一樣的藥血會流不停」。

圖 1-1

目前居家照護的困境的說明



註：此居家照護的困境圖由研究生參與中醫居家照護後構出

目前中醫及西醫居家照護中，病人位於圖中央，象徵病人為照護核心。護理師則位於病人上方，扮演「協調者」的角色，負責串聯不同專業之間的合作與溝通。在病人左右兩側，分別是兩大醫療支柱：居家中醫與居家西醫。這兩個專業體系各自負責病人的診療評估、處置與建議，再由護理師將這些療護意見告知案家。圖中多處出現紅色問號，主要分布在中醫、西醫與其他職類的交界處，代表目前在此照護模式下仍待釐清的合作機制與實務問題。

綜合以上臨床實務及實習經驗，我發現於中西醫居家照護中，無明確照會依據，不清楚可由誰啟動照會，其他職類專家能提供甚麼樣的協助，難以即時獲得適切支援。由於多種職類參與居家照護，個案的疾病狀況及相關資料，除現有系統上要求填寫的資訊外，其他更貼近病人狀況的資訊無法獲得，以至於參與居家照護的人員須重評估個案狀況。這一系列居家照護電子系統的問題、照護流程及工作內容的問題，都必須被正視。故引發研究生想藉由彙整曾參與跨領域團隊合

作與居家照護者的經驗，探討中西醫居家照護模式裡的要素為動機。考量跨領域團隊合作照護的職類眾多，較難以面對面的會議進行討論，德菲法是一種質量並重的研究方法，透過匿名以書面進行討論，可使參與者免於受權威的影響，建立專家的共識，故本研究擬以德菲法彙整曾參與跨領域團隊合作與居家照護者的經驗，探討中西醫居家照護模式之要素。

第三節 研究目的

根據研究背景及動機，本研究目的主要探討：

- 一、探討中西醫居家照護應包含的職類。
- 二、探討各職類於中西醫居家照護職責及角色。
- 三、探討各職類於中西醫居家照護的工作內容。
- 四、探討各職類於中西醫居家照護合作的關係。
- 五、探討中西醫居家照護模式。

第四節 研究問題

- 一、中西醫居家照護應包含的職類為何？
- 二、中西醫居家照護各職類於職責及角色為何？
- 三、於中西醫居家照護中各職類的工作內容為何？
- 四、於中西醫居家照護中各職類照護合作的關係為何？
- 五、中西醫居家照護模式為何？

第五節 名詞界定

- 一、跨領域團隊合作照護（Interprofessional Collaborative Practice, IPCP）

跨領域團隊合作照護是指不同專業背景的專家，透過溝通、討論及合作，結合實證資料，使醫療團隊之間的照護行為，依照病人疾病需求，由西醫師、中醫

師、護理師、藥師、復健師、營養師、呼吸治療師、物理治療師、職能治療師等，進行跨領域團隊合作照護的互動方式，有面對面交談、透過電話聯繫、透過電子系統、透過團隊討論會，決定共同目標，分享照護經驗等，獲得的最佳照護模式。

二、中醫(Chinese medicine)

透過望、聞、問、切，及陰陽、表裏、寒熱、虛等八綱問證方式，探求病因、病性、病位、分析病機及人體內五臟六腑、經絡關節、氣血津液的變化、判斷邪正消長，進而得出病名，歸納出證型，以辨證論治原則，制定治法，講求虛者實之，實者虛之，使用中藥、針灸、推拿、按摩、拔罐、食療等多種治療方式，其中藥物種類包含植物藥、動物藥及礦物藥，經治療調理後，使人體達到陰陽調和而康復。

三、西醫(Western medicine)

以解剖生理學、組織胚胎學、生物化學與分子生物學作為基礎學科，透過病史收集及問診的方式，以視診、觸診、叩診、聽診、嗅診，合併使用聽診器、叩診錘、血壓計、體溫計進行身體評估，再經科學儀器、實驗室檢查來診斷疾病，主要以西藥、手術，放射線等方式，其中藥物主要分為天然、化學合成與生物製劑，針對已發生的生理症狀進行治療根除病兆緩解症狀，做治療。

四、居家照護(Home care)

指當病患病況穩定，經中西醫醫師判定不需再住院治療可回家中療養，由醫療專業人員，包含：西醫師、中醫師、護理師、藥師、復健師、營養師、呼吸治療師、物理治療師、職能治療師，以個案健康所提供以家庭為中心的照護，其對象為失能的病人，服務的地點為居住的場所，以提供連續性與整體的健康照護。

五、德菲法(Delphi method)

德菲法又稱專家諮詢法、專家調查法，是一種兼具量化與質性之整合研究方法。研究過程中針對設定的議題，透過專家匿名以書面方式，進行多回合問卷討論，將專家的專業知能、經驗與意見建立一致性的共識，進而解決複雜議題，建構尚未成熟的機制。

第二章 文獻查證

本章根據研究目的，分為四節彙整相關文獻，依次為第一節跨領域合作照護、第二節居家照護、第三節中醫與西醫、第四節德菲法。

第一節 跨領域團隊合作照護

一、定義

IOM(2003)指出跨領域團隊合作照護即是不同專業背景的醫療人員依病人個別需求發展照護計畫，並能透過常態性的整合團隊會議，結合團隊成員彼此的知識、訊息，提供病人最佳的照護品質及增進病人安全目標。

WHO(2010)設定跨領域團隊合作照護是來自不同健康專業背景的醫療工作者，與病人、家屬、照護者及社區共同合作提供全面的照護服務，以提供最高品質的照護，這需要組成特別的健康照護工作小組，彼此建立團隊認同和共同分擔責任，提供以病人為中心的醫療照護。

二、跨領域團隊合作照護相關文獻

Sangaletti 等人（2017）針對 2000-2016 年間 21 篇探討初級照護中跨專業合作與團隊經驗的質性研究進行系統性文獻回顧與分析，涵蓋來自 8 國的醫療場域。參與者包括醫師、護理師、藥師、物理治療師、心理師、社工等多元職類，研究方法採用 Joanna Briggs Institute 的質性統整流程。研究結果綜整出三項核心發現：（一）合作行動以病人需求為中心，強調尊重、信任、溝通與共享領導等關鍵因素；（二）合作可帶來學習成長、工作整合與照護效率提升，但也面臨角色模糊、人力不足與醫師主導等結構性限制；（三）團隊合作經驗受到生物醫學主導文化、專業分工、轉介制度與教育訓練等因素深刻影響。作者強調，欲推動有效的跨專業合作，須從組織文化、政策制度與教育改革三方面共同介入。

Zwarenstein 等人（2009）針對 2000-2007 年間符合條件的實務導向跨專業合

作（Interprofessional Collaboration, IPC）介入研究進行系統性文獻回顧與分析，最終納入 5 篇隨機對照試驗（RCT），涵蓋住院病房、療養院與急性照護醫院等臨床場域。參與者包含醫師、護理人員、藥師、營養師、社工、物理治療師等專業，研究方法採用 Cochrane 有效實務與組織照護（EPOC）小組之嚴謹流程與偏誤評估工具。研究結果綜整出三類主要介入類型：（一）跨專業查房能有效縮短住院天數與醫療費用，但成效可能受病人條件與場域影響；（二）跨專業會議有助於提升用藥品質與照護計畫執行；（三）外部輔導式的跨專業稽核活動可提升照護品質與多數團隊完成完整稽核流程。然而，研究亦發現目前對「合作成效」的評估標準不一致，研究數量有限，結論難以普遍化。作者強調，推動跨專業合作的實務介入雖具潛力，但需更多具嚴謹設計的研究以驗證其效果，並建立合作測量標準與共同語彙。

Reeves 等人（2017）針對 1990–2015 年間發表之具實務導向的跨專業合作（Interprofessional Collaboration, IPC）介入研究進行系統性文獻回顧與分析，共納入來自澳洲、英國、美國、比利時與瑞典等 5 個高收入國家的 9 篇隨機對照試驗，涵蓋初級、次級、三級與社區照護場域，總樣本數達 654 人。參與者包括醫師、護理人員、藥師、社工、物理治療師、營養師、行政人員等多元職類，研究方法採用 Cochrane EPOC 的系統評估與 GRADE 確效等級分類標準。研究結果整合出四種介入類型，包括：外部引導之跨專業活動、跨專業查房、跨專業會議與跨專業檢核表。主要發現為：（一）外部引導之活動可能可略微改善中風患者功能狀態與照護資源使用效率；（二）跨專業查房與會議可改善處方行為與照護流程，但在病人主觀評估品質、照護連續性與合作行為之證據等級仍偏低；（三）整體研究結果呈現出證據不一致且異質性高，多數成效僅具「低至極低」的證據等級。作者指出，儘管實務上跨專業合作逐漸受到重視，但研究設計尚未成熟，建議未來應發展更嚴謹之混合方法研究並延長追蹤期間，以檢驗介入對照護與合作行為之長期影響。

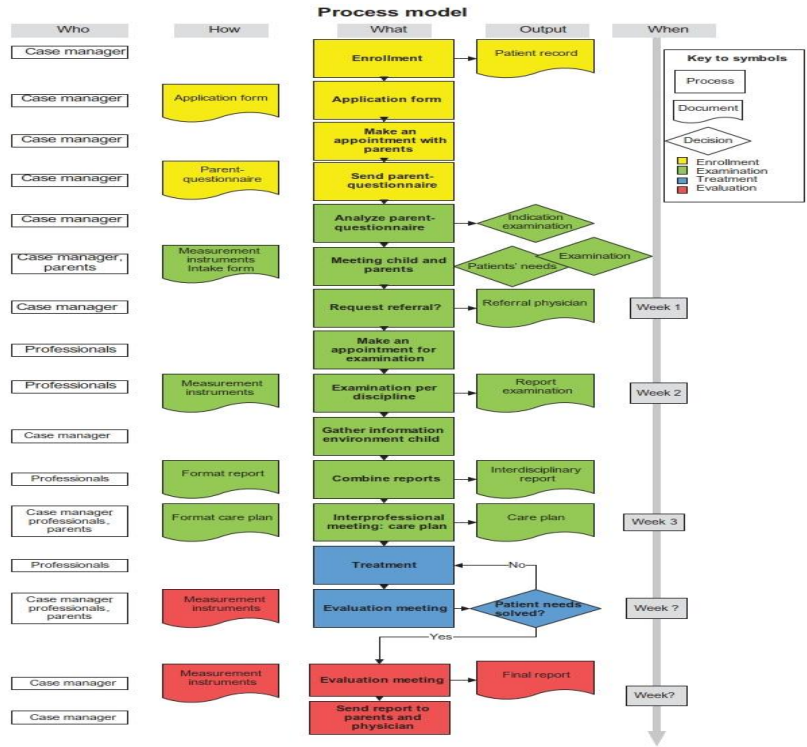
Stans et al., (2013) 「Interprofessional practice in primary care: development of a tailored process model」採用質性研究設計，引用 Grol 等人提出的五階段實施模型作為研究架構，並完成前三階段，包括：確認改善目標、分析現況及發展策略。研究者透過半結構式訪談與三次跨專業小組會議的方式，運用 Chronic Care Model (CCM) 作為分析框架，進行照護流程之探討與流程圖的設計與討論。研究對象涵蓋接受服務的兒童之家長、初級保健專業人員、保健中心主管、小學教師、家庭醫師與心理師等關鍵利害關係人，並以立意取樣方式納入，以確保意見的多元性與實務性。研究工具的發展結合實務討論與流程圖繪製，研究團隊依據 CCM 六大構面（即：自我管理支持、資訊系統、決策支持、照護流程重整、組織支持與社區資源）歸納出主要障礙與促進因子，並據此訂定具體的改善步驟。所建立的流程圖內容則清楚標示出「誰、何時、做什麼、如何執行」及「產出」，並劃分為四個階段：登記、評估、治療、與結案評估。在資料分析方面，研究採用導向內容分析法，初步編碼由一位研究者執行，再由團隊進行交叉審查，以提升信效度。共識的建立則以流程圖內容是否獲得明確一致為指標，具體包括：各階段治療內容、所需文件與工具、時程安排，以及是否指定個案管理者作為主要協調人員等。研究最終建立了一套具明確步驟與角色分工的跨專業照護流程模型 (process map) 如圖 2-1。然而，研究亦指出幾項限制，包括：缺乏整合性的跨專業溝通系統、會議與知識共享機制不足，以及財務資源有限，難以支持個案管理者角色的長期執行。研究者認為，此研究的優勢在於其理論基礎明確，結合理論與實務操作，且流程建構強調自下而上及專業主導，有效發展具體的工具與流程圖。但其限制亦明確，包括研究場域單一、樣本規模較小導致外部效度受限，且家長與其他利害關係人未參與流程建構階段。此外，此研究僅完成流程建構，尚未實際驗證成效，屬於模式建立的初步階段。

綜合以上，IOM 與 WHO 的定義強調跨領域團隊合作照護是跨專業醫療人員為病人需求而共同合作，透過資訊共享、建立目標及溝通來提供最佳照護，並

將病人、家屬納入其中。文獻指出跨領域團隊合作可提高照護效率、提升照護品質，但是臨床實務中面臨腳色模糊、溝通系統不足的問題。

圖 2-1

The visualized interprofessional practice process



註：取自”Interprofessional practice in primary care: Development of a tailored process model “by S. E. A.Stans, , J. G. A.Stevens, , & A. J. H. M Beurskens,. 2013, *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 6, 139–147.

第二節 居家照護

一、居家照護的定義

世界衛生組織(World Health Organization, WHO)在 1994 年將居家照護定義為：「於病人家中，進行整合性的健康服務」。美國護理協會（American Nurses’ Association, ANA）將居家照護定義為：「在個案所居住的環境裡，為失能或慢性疾病個案提供廣泛的健康照護」。衛生福利部將居家照護定義為：「持續性及綜合性的健康照護，在病人及家庭居住的場所提供照護服務」。

綜合上述，居家照護的特色是以個案健康所提供以家庭為中心的照護，其對

象為失能的病人，服務的地點為居住的場所，以提供連續性與整體的健康照護。

二、居家照護各職類人員的工作內容

根據《112 全民健康保險居家醫療照護整合計畫》，計畫中包含的主要職類與各自的工作內容如下：

西醫師的主要工作包括進行病人的診察、病情評估與治療計畫擬定，必要時開立藥物處方、檢驗檢查單與影像檢查單，並提供專科醫療諮詢與治療建議。護理師則負責執行居家健康評估，包括生命徵象測量、身體評估及功能狀態判定，同時進行藥物管理、衛教、傷口護理與慢性病照護，並與醫師及其他專業人員協調照護計畫。中醫師的職責涵蓋中醫診斷與治療，例如針灸、推拿及藥膳，並與西醫師合作推動中西醫整合照護，負責中藥處方與使用安全的評估。藥師則進行藥物調劑與安全使用指導，評估藥物交互作用，提供用藥諮詢，並配合醫療團隊進行藥物治療監測。營養師的工作是評估病人的營養狀況並規劃飲食計畫，針對慢性病與特殊疾病提供營養指導，並追蹤飲食執行情況與成效。呼吸治療師負責評估病人的呼吸功能，執行吸痰與氧氣治療，提供呼吸訓練與衛教（如呼吸器的使用），並監測血氧飽和度與呼吸相關參數。社工師的任務在於提供病人與家屬心理社會支持，進行社會資源評估與連結，並協助長照資源與補助的申請。復健師則協助患者進行復健運動，評估與改善肢體活動功能，提供輔具選用與訓練建議，並訓練患者的日常生活功能與自理能力。

三、居家照護相關文獻

白惠文等（2019）於「醫院與居家醫療照護整合計劃－以嘉基經驗為例」，寫到因失能或疾病導致就醫不便的民眾逐漸增加，使其無法獲得醫療照護。而病人住院中由出院準備小組護理師進行的出院準備，除減少再入院外，也能即早進行返家後的準備。而良好的居家醫療服務模式需有高度協調性及連續性照護，醫院端在體系內的資源統和為重要的角色，讓願意為居家醫療付出的醫師們，能藉由行政體制的改變，促成跨領域間的溝通與聯繫，透過「連續性照護之訊息共享

資訊系統」，提供不同的專業領域，包括醫療、長照、物理治療師、營養師等不同照護體系的醫療成員，能得到病人的訊息及分享，以能確保個案能獲得連續性、即時性、完整性及一致性的照護。但目前尚無適合的資訊系統，讓跨專業領域成員們能進行溝通討論。

吳孟嬪等（2019）在「建構完善的台北市居家安寧照護模式」中寫到，為居住在家中的生命末期個案，以居家照顧方式提供醫療照護，重視個案的連續性照護品質，同時運用社區內外部資源，結合社區公衛與長期照顧資源，同時整合院內各專業人員，包含醫師、護理師、呼吸治療師、社工師、心理師、營養師、藥師及職能治療師等，提供跨域的整合性專業團隊服務，提供以人為中心的安寧居家療護，後續期望將資訊系統建置及整合，將原紀錄表單，結化構後與資訊室人員共同討論研發建置一系列無縫接軌的整合性資訊系統，透過跨領域、跨院際合作，增進社區與其他醫療團隊的互動，使個案獲得醫療服務的可近性、持續性。

施秀樺等（2021）「從國內居家整合照護計畫探討安寧緩和整合照護模式新契機」說明，結合跨專業團隊服務，包含醫師護理師藥師社工心理師等，在醫療團隊合作過程中，居家護理師扮演重要的協調及代言的角色，除進行訪視外，依照個案病程發展階段需求協調各領域照護團隊，以提供連續性、適切之服務，文中強調早期安寧照護介入可減少不必要醫療資源使用，提升病人與家屬生活品質並實踐在地老化與在宅善終理念。此外指出中醫加入可提升照護多元性，協助緩解癌症相關症狀，並主張資訊系統整合與政策支持為推動成功關鍵。整體而言，建立以個案為中心、具整合性與可近性的安寧照護體系是提升末期照護品質與滿足個案善終願望的重要方向。

綜合上述，居家照護團隊包含醫師、護理師、呼吸治療師、社工師、心理師、營養師、藥師及職能治療師，透過資訊系統的共享，使個案能達到連續性、即時性的照護。

第三節 中醫與西醫

一、中醫

中醫將人體看成氣、形、神合一的整體，講求虛者實之，實者虛之，使人體達到陰陽調和，《黃帝內經》提出了一種整體觀念，強調身體、心靈和環境的相互關聯，並著重於預防及平衡來維持健康。以中醫學理論為基礎，透過望、聞、問、切，及陰陽、表裏、寒熱、虛實等八綱問證方式進行診治，探求病因、病性、病位、分析病機及人體內五臟六腑、經絡關節、氣血津液的變化、判斷邪正消長，進而得出病名，歸納出證型，以辨證論治原則，明白個體之間差異，因此有「同病異治」、「同病治異」的說法，治則以使用中藥、針灸、推拿、按摩、拔罐、食療太極與氣功等多種治療方式，經治療調理後，使人體達到陰陽調和而康復(陳麗麗等，2011)。

二、西醫

西醫以解剖生理學、組織胚胎學、生物化學與分子生物學作為基礎學科，隨著顯微鏡的發明與血液循環理論的發現，開始研究人體的生理現象與病理現象的過程，針對已發生的生理症狀做治療。隨著科學革命確立了細菌理論，並研究出消毒法及疫苗，更發展出X光及青黴素。透過病史收集及問診的方式，以視診、觸診、叩診、聽診、嗅診，合併使用聽診器、叩診錘、血壓計、體溫計進行身體評估，再經科學儀器、實驗室檢查來診斷疾病，主要以西藥、手術，放射線等方式進行治療，透過現代化的科學儀器，使其在急性或緊急醫療方面，有好的成效(林能傑，2011)。

三、中醫與西醫合作上的問題

中西醫在診斷與治療思維上存在差異，且缺乏共同的溝通平台與病歷資訊共享機制，導致資訊不對稱，難以形成整合性的照護共識。此外，由於醫護人員缺乏中西醫相關的專業訓練，且沒有標準化的整合性醫療計畫，中西醫可能各自為政，無法為病人提供全面、連貫的照護(黃頌儼，2019)。中醫在政策推動上較

晚才被納入「居家醫療整合照護計畫」，顯示其角色認可起步較晚，中醫在納入後，在「利用、支付與收案」等執行層面也仍面臨挑戰（陳品璇等，2022）。透過專業教育與訓練，提升醫護人員對中西醫的認知與技能，使合作更為順暢，應建立嚴謹的品質管理與評估機制，確保醫療品質並持續優化服務（黃頌儼，2019）。值得一提的是，合作時應充分發揮中醫在老年失能照護方面的獨特優勢，如預防失能、減緩失能加重程度，以提高整體照護品質（陳品璇等，2022）。

第四節 德菲法

一、定義

德菲法(Delphi method)又稱德懷術、專家諮詢法、專家調查法或專家規定程序調查法，是一種兼具量化與質性之整合研究方法。研究過程中針對設定的議題，透過專家匿名以書面討論方式，誘導專家以其專業知能、經驗與意見，計量出多數專家的看法，以建立專家群一致性的共識，進而解決複雜議題。不僅可排除質性研究不夠嚴謹的缺點，同時將量化研究之科學性與系統性應用更充裕。在醫療衛生政策的領域中，常面臨高度變化的政策，對於要預測未來的多變情況下，德菲法為常被應用的研究方法（宋文娟，2001）。

二、特點概述

德菲法(Delphi method)是一種旨在透過匿名專家群體的意見來達成共識的決策方法，其優勢在於不需大量的樣本，但樣本必須具有代表性（宋文娟，2001；Wilkes, 2015）。根據宋文娟（2001）的整理，德菲法包含六個核心要素：專家小組、信度與效度、匿名性、迴饋控制、一致性，以及研究者的角色扮演。其優點在於能夠集思廣益、凝聚共識，提供可信的資訊。由於專家匿名填寫問卷，可以避免權威或群體壓力對結果的影響，讓專家能客觀地表達意見，且最終結果可以進行描述性統計分析。此外，該方法突破了時空限制，可透過電子或郵寄方式向不同地區的專家收集資料，並且不需複雜的統計學，只需利用描述性統計就能呈

現專家意見（Van Vliet et al., 2016；McPherson et al., 2018）。然而，德菲法也有其缺點。如果專家小組的代表性不足或同質性高，缺乏不同見解，可能會產生偏見（宋文娟，2001）。此外，部分專家可能不願意分享與大多數人不同的觀點，而改變主意以趨向共識。若研究過程中參與者流失，可能導致研究結果產生偏差，因此當問卷回收率低於 50%時，應進行催覆提醒（宋文娟，2001；McPherson et al., 2018）。另一個缺點則是問卷收集較為耗時（宋文娟，2001）。

在執行上，德菲法通常透過數個回合的問卷調查來達成共識。第一回合為開放式問題，旨在匯集專家的意見和想法，並將其數據進行描述性統計分析，作為第二回合問卷編擬的依據。第二回合則使用量表評分法，讓專家填寫意見。第三回合同樣利用描述性統計呈現結果，專家可參考後進行補充及修正。整個過程會至少進行二到三輪，直到專家意見達成共識為止（宋文娟，2001；Keeney et al., 2011）。在專家小組的組成方面，通常建議人數在 10 到 30 人之間，且需具備代表性，能夠公正地反映知識或看法（宋文娟，2001；Murray & Hammons, 1995）。

三、德菲法應用於照護相關研究

鑒於德菲法在健康照護模式建構中的廣泛應用，本文彙整相關文獻，以探討不同領域如何透過專家共識，發展具實務價值的指標或能力架構。下列表2-4呈現德菲法相關研究，討論法在跨領域合作中的運用與成果。

Lodewijckx et al., (2012) 「Quality indicators for in-hospital management of exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: Results of an international Delphi study」透過國際性的德菲法整合專家意見，以篩選出適用於住院期間慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化照護的品質指標。該研究採用兩回合的國際性德菲法設計，為期四個月，目標是從流程與結果層面選出能夠有效評估照護品質的指標。根據文獻回顧與臨床實務，設計出93項指標，其中包含72項流程指標與21項結果指標。隨後，研究邀請來自15個國家、共35位具有COPD臨床照護或照護路徑研究經驗的專家參與，這些專家背景多元，涵蓋了醫師、護理師與物理治療

師。在兩輪的問卷評分過程中，研究採用百分比分析，將獲得75%或以上專家認同的指標視為達成共識。研究結果顯示，最終有36項指標獲得共識，其中包括26項流程指標和10項結果指標。在這些指標中，獲得最高共識的流程指標包括氧氣治療（100%專家認可）與肺復健（100%），以及病人教育（94.5%~88.6%）。而最高共識的結果指標則為病人對治療的理解（91.4%~85.7%）和自我照護能力（88.6%~88.2%）。這些指標之所以被選定，其關鍵在於專家們認為它們同時具備臨床重要性、在照護路徑中具有追蹤意義，且可實際蒐集並應用於品質改善。作者在評估此研究的優缺點時指出，其優點在於採用了結構嚴謹且具匿名性和回饋性的德菲法，且專家來自多國多專業，使研究結果具備國際代表性。所提出的指標集也具備實務應用價值，可作為未來品質研究的依據。然而，缺點在於研究受限於2008年當時的知識與實務，部分指標可能已過時，且指標的可操作性與蒐集可行性仍需進一步實證。此外，研究僅進行兩輪德菲，可能影響了部分指標未能達成最終共識。

紀淑靜等人(2015)「運用德菲法建構腦中風急性後期照護護理人員應具備之核心能力」作為未來教育訓練規劃的依據。研究團隊在2014年6月至8月間，透過三回合的匿名問卷調查，收集了18位跨領域專家的意見。這些專家涵蓋護理、醫療、公衛與學界領域，皆具備PAC實務或學術經驗。研究工具為「PAC護理人員核心能力調查表」的問卷，其內容根據文獻與PAC實務經驗設計，包含29項核心能力指標，並分為「個案照護」與「照護管理」兩大層面。問卷使用七點量表，評估每項能力的「重要性」與「可行性」。在統計分析方面，研究採用描述性統計，以眾數、平均數和標準差來分析數據，並將獲得75%以上專家評為5至7分的指標，且標準差小於前一回合的指標，視為達成共識。研究結果顯示，所有29項核心能力在「重要性」層面都獲得了專家們的共識，其中包括評估營養、疼痛、睡眠、翻身擺位、照護衛教、家庭支持評估等。最終，研究回收率達81.4%，證明其具備代表性。該研究的關鍵在於強調理論與實務的結合，並運用

Gordon 健康功能評估架構與 PAC 實務文獻，以確保調查表具備內容效度。作者評估本研究的優點在於，其採用了結構嚴謹且反覆驗證的德菲法，並結合量化與質性分析，提升了資料的解釋力。所得到的結果具體可用於教育訓練與政策規劃。然而，研究也存在一些缺點，例如調查僅限於台灣地區的專家，其國際通用性尚待驗證。此外，在「可行性」評估上仍有部分分歧，這顯示出制度與文化因素所帶來的挑戰。作者建議，未來應將此核心能力指標納入實地執行或驗證階段，以進一步確認其有效性。

Vogel et al., (2019)「A Delphi study to build consensus on the definition and use of big data in obesity research」透過三回合的德菲法，釐清「大數據」在肥胖研究中的定義與應用方式。研究邀請來自肥胖研究領域的國際專家，針對七大主題的 85 項敘述進行評估。採用匿名問卷方式，在三回合中反覆收集與整合專家意見，每一回合都會提供前一回合的回應摘要，藉此鼓勵參與者重新評估自己的觀點。研究對象為 96 名來自 OECD 國家的學術機構成員，這些專家需年滿 18 歲、精通英文，並活躍於肥胖研究或相關大數據應用領域。最終，有 26 名專家完成了三回合的調查。問卷內容根據文獻回顧與 Obesity Network 的實務經驗設計，涵蓋大數據定義、資料取得、倫理、治理、訓練、報告透明度與品質推論等七大主題。研究採用描述性統計分析，並將 70% 以上專家「同意或強烈同意」或「不同意或強烈不同意」的敘述視為達成共識。結果顯示，共識進展從第一回合的 64.5% 提升至第三回合的 90.6%，尤其在大數據定義領域的 15 項敘述中，最終全部達成共識。作者評估研究的優點在於，它系統性地整合了多國多專業的專家意見，具備高信效度，並為大數據在肥胖研究中的應用提供了具體的操作建議，彌補了現有文獻的缺口。這項研究成果有助於未來研究框架的建構與跨國比較。然而，研究也存在一些缺點，例如參與者以英國學者為主，地區代表性受到限制，且最終回應率較低（約 27%），可能存在選擇偏差。此外，研究並未針對實際資料分析的設計與驗證進行深入探討。

表 2-1

德菲法相關研究

作者(年)	研究目的	跨領域合作對象	研究方法	研究結果
Lodewijckx et al. (2012)	建立 COPD 住院期照護品質指標	35 位專家 (醫師、護理師、物理治療師)，來自 15 個國家	2 回合國際 Delphi 研究，2008 年，4 個月	共 36 項品質指標達成共識 (26 流程、10 結果)，氧氣治療、肺復健等獲 100% 共識，75% 為共識門檻
紀淑靜等人 (2015)	建構腦中風 PAC 護理人員核心能力	18 位 PAC 照護領域專家，含護理、醫療、公衛、學界	3 回合修正式 Delphi 法，2014 年 6-8 月，2 個月	確認 29 項能力全數獲 75% 以上專家共識，回收率 81.4%，包含照護、溝通、管理、團隊合作等能力
Vogel et al. (2019)	建立大數據於肥胖研究中之定義與應用建議	96 位來自 OECD 國家肥胖與大數據研究專家，26 位完成 3 回合	3 回合 Delphi 法，匿名問卷，涵蓋 85 項敘述，穩定性分析	90.6% 敘述達 70% 以上共識，大數據定義與應用 (資料治理、倫理、品質推論) 達高度一致，提供具體建議

第三章 研究方法

本研究以德菲法探討中西醫居家照護模式之要素。依研究目的，期望能促居家照護中各跨領域團隊的溝通、合作及照護連續性，進而增進照護品質，本研究採用質量並重的德菲法(Delphi Method)進行，為避免傳統德菲法開放性問卷回收率低之問題，改善問卷多次往返的耗時、回收率低等缺點，「修正式德菲法」在研究方法上，保留傳統德菲法的精神，將第一回合以文獻探討方式擬定半結構式問卷，取代用開放式問卷匯集，使專家聚焦於研究主題，專家意見聚合現象出現於三回合之間，具節省時間、經費及提升問卷回收率等優勢（張、鍾，2009）。

第一節 研究設計及工具

本研究採用可有效彙整專家意見的德菲法進行。根據研究目的，彙整相關文獻後編製第一回調查問卷，以實際參與居家照護的各級專家為對象，進行三回合專家意見調查，取得專家群共識。

第二節 研究場所及研究對象

一、研究場所

2024 年 3 月至 2025 年 5 月於台灣同一體系之兩間醫學中心區及大學。

二、研究對象

以台灣地區目前對中醫、西醫、居家照護、跨領域團隊合作照護之學者專家為對象，且須具備與研究目的相關之經驗，能提供資訊供本研究參考，須符合以下特性：

- (一)曾或現正在參與居家照護
- (二)曾發表過居家照護相關文章
- (三)曾或現正執行居家照護相關計畫
- (四)曾或現正參與跨領域團隊合作照護
- (五)曾發表過跨領域團隊合作照護相關文章

(六)曾或現正執行跨領域團隊合作照護相關計畫

(七)本研究議題有興趣，願意全程參與者

以上符合 1-6 項其中一項，及必要條件第 7 項符合者，即可納為研究對象。

排除條件：

(一)無法提供有效資訊者

(二)對研究主題不感興趣者

透過通訊軟體、電子郵件信箱方式進行邀請，以紙本寄送或親送研究目的、方法、流程、研究對象同意書、問卷及受試者禮券簽收明細等相關資訊，使各專家了解本研究預期探討符合臨床實務之「中西醫居家照護模式」之要素。為往後中醫居家照護中，各跨領域團隊的溝通、合作及照護連續性，進而增進照護品質。因此專家成員須依此目的，依據個人的專業知識與實務經驗，進行問卷中各部分工作項目的勾選，以及意見的陳述。

第三節 資料處理與分析

針對調查工具進行多次編修，質性資料以 Excel 列出專家對各題項的意見，進行分析和歸納。量性資料以 Excel 進行編碼建檔，以 SPSS Version 27 軟體，針對每位專家所提建議進行統計與分析。採用描述性統計，計算量化資料百分比、Fleiss' Kappa（表 3-1）。

表 3-1

描述性統計分析說明

描述性統計		
研究目的	變項分類	統計方式
1. 中西醫居家照護應包含的職類。	類別	百分比、 Fleiss' Kappa、 穩定度分析
2. 中西醫居家照護各職類於職責及角色。		
3. 於中西醫居家照護中各職類的工作內容。		
4. 於中西醫居家照護中各職類照護合作的關係。		
5. 探討中西醫居家照護模式		

1. 百分比 (Percentage)：是一種用來表示某數值佔總數或整體的比例。百分比共識，當百分比共識達 90%以上 時，表示專家之間達成幾乎完全一致，此為最強的一致程度；若落在 80%至 89% 之間，則可視為良好一致，顯示有高度的共識。若共識比例在 70%至 79%，可解釋為中等一致，表示意見趨於一致但尚有些微分歧；而 60%至 69% 則被視為適度一致，仍具一定共識但尚不穩定。當百分比共識僅有 50%至 59%，則顯示專家間僅有輕微一致，共識程度相對較低；而若低於 50%，則被視為低於隨機一致，表示缺乏明確的共識，甚至可能不如隨機結果的分布。
2. Fleiss' Kappa：用於評估三位或三位以上的評分者，對於每一題項的共識情形，當 Kappa 值大於等於 0.61 屬有初步共識，值愈接近 1 表示評分者之間的評估趨於共識，如表 3-2 Kappa 區間定義(Landis & Koch, 1977)。
3. 穩定度分析：指在不同回合間，受試者對同一題目的回答是否保持共識，當穩定度 $\geq 80\%$ ，為高穩定度，意見已趨於共識，可終止調查穩定度越高，代表受試者的意見越不容易改變，整體趨向共識與定型。

表 3-2

Kappa 區間定義

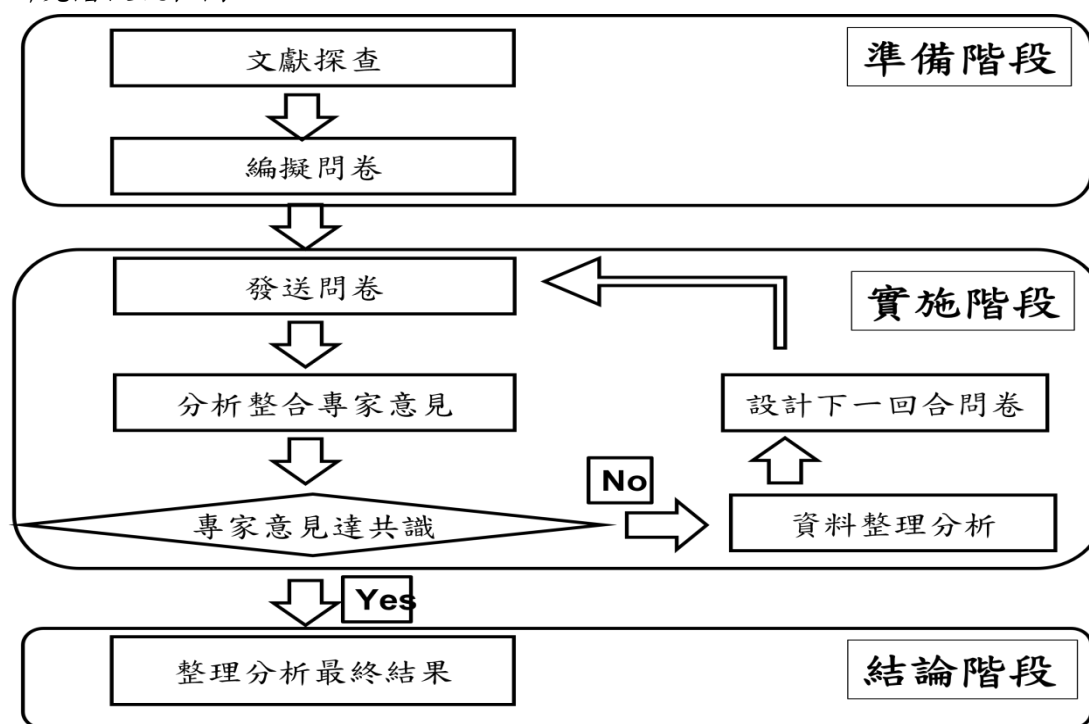
Kappa 值區間	英文	中文
< 0.00	Poor	完全無共識
0.00 – 0.20	Slight	幾乎無共識
0.21 – 0.40	Fair	共識薄弱
0.41 – 0.60	Moderate	有初步共識
0.61 – 0.80	Substantial	已具明顯共識
0.81 – 1.00	Almost Perfect	高度共識

第四節 研究步驟

本研究目的在於以「德菲法探討中西醫居家照護模式」之要素，研究進行的步驟分為準備、實施及結論三的階段進行(如圖 3-1)，分述如下：

圖 3-1

研究階段流程圖



一、準備階段

(一) 問卷封面：載明研究主題（第一回合）、專家編號、聯絡方式（電話、地址、電子信箱）、問卷回收日期。

(二) 研究說明：陳述研究動機、研究目的、專家遴選條件、問卷實施方式及程序、問卷回收日期、研究者聯絡方式。

(三) 基本資料表：性別、職稱、工作經驗、學歷、服務單位、參與居家照護的經驗、參與跨領域團隊合作照護經驗、擔任探討「中西醫居家照護」專家之意願、異動之聯繫方式。

(四) 問卷填答說明：此部分答題注意事項提醒，此階段採半結構式問卷，請專家勾選最符合之的選項，增列一題「其他」以收集未盡問卷未能涵蓋的資料。

(五) 選定專家: Murray & Hammons(1995) 指出關於 Delphi 樣本數的最佳數量的文獻參差不齊。普遍認為，大小沒有上限，只要選擇有代表性的樣本即可。因本研究屬異質性高的專家團體，因此，本研究邀請 25 位台灣同一體系內兩間醫學中心及大學之專家，包含西醫師、護理師、社工師、營養師、呼吸治療師、復健師、藥師擔任專家（表 4-1）。為增加專家間的異質性，將邀請學者以及醫學中心內符合收案條件者參與本研究。

二、實施階段

(一) 第一回合問卷

第一回合問卷包含三個部分（評估、療護計畫與執行、團隊合作）及各職類參與居家照護需取得資料共 135 個題項。請專家詳細閱讀本研究目的、流程及問卷填答說明後，針對最符合現況及期望的選項打勾，如有選項位涵蓋的項目，於每一題最後面設有「其他」欄位，請專家陳述意見。

於 2024 年 4 月 5 日陸續發出 25 份德菲法專家問卷，至 2024 年 5 月 25 日回收完畢，寄出 25 份問卷，回收 24 份問卷，流失 1 位，回收率 96%。專家群在第一回合問卷中，針對 3 大部分及 22 個類別依現況及期望填寫的結果進行百分比統計，見表 4-2。進行歸納及整理，使用 Excel 試算表軟體進行量性資料分析，以百分比呈現。題項刪除及修改條件為，75%以上專家期望能做的工作項目，及專家建議修改項目，於修訂後納入下一回合問卷題項，形成結構式問卷。

(二) 第二回合問卷

依據第一回合專家意見及問卷統計分析的結果編修而成，分類為六大部分：含居家評估收案與紀錄、第一次案家訪視評估與紀錄、執行療護與紀錄、其他職類參與居家照護、跨領域團隊合作會議及參與居家照護需要得知的資料，共計 110 題，其中西醫居家照護順序圖。依據德菲法研究概念，於寄出第二回合問卷時，將同時檢附第一回合問卷中「專家於第一回合問卷填答的資料」、「專家意見」、「問卷修改、合併及刪除的項目」、「第一回合專家意見統計結果」等說明文件，以提供專家在進行第二回合問卷填答時作為參考使用。第二回合專家問卷以二分

法進行填答，每題最後面設有「修改建議」欄位，請專家陳述意見。

第二回合德菲法問卷調查，於 2024 年 12 月 25 日陸續發出 24 份德菲法專家問卷，至 2025 年 2 月 15 日回收完畢，寄出 24 份問卷，回收 24 份問卷，回收率 100%。專家群在第二回合問卷中，針對 6 大部分進行共識。

問卷回收後，進行歸納及整理，以 Excel 試算表軟體進行量性資料分析，以百分比呈現。將專家共識納入第三回合問卷。刪除標準為，專家共識小於 75% 的工作項目，將修訂或刪除後納入下一回合問卷題項，形成結構式問卷。

(三)第三回合

第三回合德菲法專家問卷，為第二回合專家意見及問卷統計分析的結果共識而成，分類為六個部分，含居家評估收案與紀錄、第一次案家訪視評估與紀錄、執行療護與紀錄、其他職類參與居家照護、跨領域團隊合作會議及參與居家照護需要得知的資料，共計 110 題。

於 2025 年 5 月 24 日陸續發出 24 份問卷，包含中西醫居家照護流程圖及德菲法專家問卷，至 2025 年 6 月 1 日回收完畢，寄出 24 份問卷，回收 24 份問卷，回收率 100%，採用 Fleiss' Kappa 分析。

問卷回收後，進行歸納及整理，第一至第五部分以各題項的答案進行 Fleiss' Kappa，專家一致性分析，當 Kappa 值大於等於 0.61 高一致性(Substantia)，表示專家對於該工作項目具有共識性(Landis & Koch, 1977)及穩定度計算當 $\geq 80\%$ 可視為高穩定度，專家意見趨一致；第六部分，分析各職類參與居家照護需取得資料項目，以 Excel 試算表軟體進行量性資料分析，以百分比呈現，當百分比大於 50，表此項目資料為該職類所需要，根據第三回合專家意見，集結專家共識建立中西醫居家照護模式之要素。

(四)結論階段

彙整第三回合問卷，以統計軟體進行資料處理後，建立中西醫結合居家照護模式要素。

第五節 研究倫理考量

本研究於 2023 年 9 月 30 日經佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院研究倫理委員會(Institutional Review Board, IRB) (附錄一、二) 核准同意，計畫編號 IRB112-209-B，計畫執行中以研究對象自主及知情同意的倫理考量原則，尊重及保障研究對象權利、安全及倫理作為優先考量。經審核通過後，使用書面或電子信件，向研究對象說明研究目的及執行步驟，並徵詢其同意始進行資料收集。研究者對所收集的資料絕對保密，將專家回覆之問卷回收後，電腦輸入資料以加密方式妥善保存，未來發表研究相關的結果時，也不會出現機構的名稱及專家姓名等資料，對於個案相關資料，一律由研究者自行保管、整理、分析，妥善保存於慈濟醫院感恩樓九樓可上鎖之櫃內，並保存 10 年後即予以全數銷毀，不做研究以外的用途。研究進行中若個案有任何參與研究的相關問題，將給予適切的說明。研究過程雖無侵入性傷害，倘若因焦慮或心理障礙，有權利隨時停止，退出研究。

第四章 研究結果

第一節 專家組成

招募過程中，取得 24 位專家學者參與，並簽署完成「研究對象同意書」。專家成員基本資料(如表 4-1)呈現如下，本研究專家成員職類分布方面，以護理師 8 位 (33.3%)，中醫師 4 位 (16.7%)、復健師 3 位 (12.5%)、西醫師、藥師、社工師與營養師各 2 位 (皆為 8.3%)，呼吸治療師 1 位 (4.2%)。參與的專家在居家照護及跨領域團隊照護領域的平均年資為 13.3 年，顯示其具有豐富實務經驗與專業背景，足以提供本研究穩定且具參考價值之專業意見。基於德菲法研究精神及對研究參與對象的保護，本研究不會個別披露專家的身份，後續將以 R001 至 R024 作為專家代號進行闡述。

表 4-1

專家成員基本資料(N=24)

編號	性別	職稱	學歷	收案符合的項目
R001	女	護理師	碩士	①②③④⑦
R002	女		大學	①③④⑦
R003	女		碩士	①④⑥⑦
R004	女		大學	①④⑦
R005	女		大學	④⑦
R006	女		大學	①②③④⑦
R007	女		博士	①④⑦
R008	女	中醫師	博士	①②④⑦
R009	男		碩士	①④⑦
R010	男		碩士	①④⑦
R011	女		碩士	①④⑦
R012	女		碩士	①④⑦
R013	女		大學	①④⑦
R014	女		博士	①④⑥⑦
R015	女	呼吸治療師	碩士	①④⑦
R016	女		碩士	①⑦
R017	男		碩士	①③④④⑦
R018	女	復健師	碩士	①⑦
R019	男		大學	①③④④⑦
R020	女		大學	①③④④⑦
R021	女	西醫師	大學	①④⑦
R022	女		大學	①⑦
R023	女		大學	①⑦
R024	女	營養師	碩士	①④⑦
R025	女		碩士	①⑦

註：收案符合的項目：①曾或現正在參與居家照護②曾發表過居家照護相關文章③曾或現正執行居家照護相關計畫④曾或現正參與跨領域團隊合作照護⑤曾發表過跨領域團隊合作照護相關文章⑥曾或現正執行跨領域團隊合作照護相關計畫⑦本研究議題有興趣，願意全程參與者

第二節 第一回合德菲法專家問卷研究結果

第一回合涵蓋 3 大部分與 22 類別。依文獻建議 (Hasson et al., 2000)，以「專家期望 $\geq 75\%$ 」為保留門檻，並綜合意見進行題項整併；原 135 題整併 28 題後，保留 110 題作為第二回合基礎。

第一個部分「評估」，共八類，包含收案、身體、中醫、管路、營養、呼吸、生活、用藥評估。依專家意見與臨床現況進行合併或刪減，詳見表 4-2。在第一類中「決定居家收案評估、決定是否收案、決定西醫收案、決定中醫收案」五位專家建議可合併工作項目為居家照護收案評估、決定收案與紀錄；第二類中「呼吸系統、心血管系統、腸胃系統、神經系統、內分泌系統、淋巴系統、生殖系統、泌尿系統、皮膚系統、肌肉骨骼系統」四位專家建議可合併工作項目為系統性回顧評估；第三類中「望診、聞診、問診、切診」兩位專家建議可合併工作項目為四診評估；第四類中「鼻胃管、尿管、氣切管」三位專家建議可合併工作項目為留置管路；第六類中「拍痰技巧、家用呼吸器使用狀況、蒸氣吸入使用狀況、抽痰技巧」兩位專家建議可合併工作項目為呼吸照護；第七類中「社會福利需求、無障礙生活環境、適用的輔具、喘息服務」四位專家建議可合併工作項目為社區資源轉介；第八類「過去用藥、現在用藥、多重用藥」合併為用藥史」六位專家建議可合併工作項目為用藥史。

表 4-2

第 1 回合-第一部分評估 專家意見及統計結果(N=24)

工作項目	由誰做	期望能做(%)	工作項目修改
第一類收案評估			
1-1 決定居家收案評估	護理師	100	根據 5 位專家的建議，將 1-1 至 1-4 合併為 居家照護收案評估、決定收案與紀錄
1-2 決定是否收案	西醫師 中醫師		
1-3 決定西醫收案	西醫師	100	
1-4 決定中醫收案	中醫師	100	
第二類身體評估			
2-1 過去病史	護理師 西醫師 中醫師	100	
2-2 現存疾病	護理師 西醫師 中醫師	100	
2-3 呼吸系統	護理師	100	根據 4 位專家的建議，將 2-3 至 2-12 合併為系統性回顧評
2-4 心血管系統	西醫師		
2-5 腸胃系統	中醫師		
2-6 神經系統			
2-7 內分泌系統			
2-8 淋巴系統			
2-9 生殖系統			
2-10 泌尿系統			
2-11 皮膚系統			
2-12 肌肉骨骼系統			
第三類中醫評估			
3-1 望診	中醫師	100	根據 2 位專家的建議，將 3-1 至 3-4 合併為四診評估
3-2 聞診	中醫師	100	
3-3 問診	中醫師	100	
3-4 切診	中醫師	100	
第四類管路評估			
4-1 鼻胃管	護理師	100	根據 3 位專家的建議，將 4-1 至 4-3 合併為留置管路
4-2 尿管	西醫師		
4-3 氣切管	中醫師		
第五類營養評估			
5-1 營養狀況	護理師 西醫師 中醫師	100	
5-2 吞嚥功能	護理師 西醫師 中醫師	100	
第六類呼吸照護評估			
6-1 拍痰技巧	護理師	100	根據 2 位專家的建議，將 6-1 至 6-4 合併為呼吸照護
6-2 家用呼吸器使用狀況	西醫師	100	
6-3 蒸氣吸入使用狀況	中醫師	75	
6-4 抽痰技巧	護理師	100	
	西醫師 中醫師	100 75	
第七類生活評估			
7-1 社會福利需求	護理師	100	根據 4 位專家的建議，將 7-1 至 7-4 合併為社區資源轉介
7-2 無障礙生活環境	西醫師		
7-3 適用的輔具	中醫師		
7-4 喘息服務			
第八類用藥評估			
8-1 過去用藥	護理師	100	根據 6 位專家的建議，將 8-1 至 8-3 合併為用藥史
8-2 現在用藥	西醫師		
8-3 多重用藥	中醫師		

第二部分「療護計畫與執行」，共十三類：醫療處置、管路照護/衛教、身體照護/衛教、中醫衛教、營養照護/衛教、呼吸照護/衛教、生活照護、用藥指導、評估。依專家意見與臨床現況進行合併或刪減，詳見表 4-3 至表 4-4。第一類中「開立處方」依臨床現況，更名為開立醫囑；第二類中「更換鼻胃管、更換尿管、更換氣切管」依臨床現況，更名為更換留置管路；第三類中「鼻胃管護理、尿管護理、氣切管護理」依臨床現況，更名為留置管路衛教；第四類中「翻身擺位、轉位、被動關節運動、身體活動照護」兩位專家建議可合併工作項目為身體清潔與舒適照護；第五類中「翻身擺位衛教、轉位衛教、被動關節運動衛教」兩位專家建議可合併工作項目為身體清潔與舒適照護衛教；第六類中「熱療照護衛教、電刺激照護衛教、推拿照護衛教、針灸照護衛教、穴位按壓照護衛教、刮痧照護衛教、拔罐照護衛教」三位專家建議可合併工作項目為中醫照護衛教；第七類中「營養調配、飲食宜忌、改善營養不良/改善營養過多」一位專家建議可合併工作項目為營養衛教；第九類中「拍痰、抽痰、呼吸器照護、蒸氣吸入照護」三位專家建議可合併工作項目為呼吸照護；第十類中「拍痰衛教、抽痰衛教、呼吸器衛教、蒸氣吸入衛教」三位專家建議可合併工作項目為呼吸照護衛教；第十一類中「提供會福利資源相關資訊、提供無障礙環境建議、建議輔具選購、提供喘息服務建議」兩位專家建議可合併工作項目為社區資源轉介；第十二類中「藥物保存、用藥安全、藥物交互作用、廢棄藥物處理」兩位專家建議可合併工作項目為用藥指導；第十三類中「評估照護成效、決定中醫結案、決定西醫結案」三位專家建議可合併工作項目為評估照護項目執行成效。

根據專家意見，此部分的工作項目由西醫師、中醫師及護理師執行，專家期望能做的比例介於 62%至 100%，其中護理師在身體照護、管路照護、呼吸及衛教等項目達 100%共識，西醫師與中醫師則在診斷與醫療處置相關項目達 100%共識。

表 4-3

第 1 回合-第二部分療護計畫與執行 專家意見及統計結果(N=24)

工作項目	由誰做	期望能做(%)	工作項目修改
第一類醫療處置			
9-1 擬定療護計畫	護理師	100	-
	西醫師		
	中醫師		
9-2 開立處方	西醫師	100	依臨床現況，修訂題目為開立醫囑
	中醫師		
9-3 檢體採集	護理師	100	-
	西醫師		
9-4 傷口照護	護理師	100	-
	西醫師	100	
	中醫師	75	
9-5 熱療	護理師	62	-
	中醫師	75	
9-6 電刺激	護理師	62	-
	中醫師	75	
9-7 推拿	中醫師	100	-
9-8 針灸	中醫師	100	-
9-9 穴位按壓	護理師	100	-
	中醫師		
9-10 刮痧	中醫師	100	-
9-11 拔罐	中醫師	100	-
第二類管路照護			
10-1 更換鼻胃管	護理師	100	依臨床現況，修訂題目為更換留置管路
10-2 更換尿管	西醫師		
10-3 更換氣切管			
第三類管路衛教			
11-1 鼻胃管護理	護理師	100	依臨床現況，修訂題目為留置管路衛教
11-2 尿管護理	西醫師		
11-3 氣切管護理			
第四類身體照護			
12-1 翻身擺位	護理師	100	
12-2 轉位			
12-3 被動關節運動			
12-4 身體活動照護			
第五類身體照護衛教			
13-1 翻身擺位衛教	護理師	100	根據 2 位專家的建議，將 13-1 至 13-3 合併為身體清潔與舒適照護衛教
13-2 轉位衛教			
13-3 被動關節運動衛教			
第六類中醫照護衛教			
14-1 熱療照護衛教	護理師	100	根據 3 位專家的建議，將 14-1 至 14-7 合併為中醫照護衛教
14-2 電刺激照護衛教	中醫師		
14-3 推拿照護衛教			
14-4 針灸照護衛教			
14-5 穴位按壓照護衛教			
14-6 刮痧照護衛教			
14-7 拔罐照護衛教			
第七類營養照護			
15-1 營養調配	中醫師	100	根據 1 位專家的建議，將 15-1 至 14-3 合併為營養照護
15-2 飲食宜忌	西醫師		
15-3 改善營養不良/改善營養過多	護理師		
第八類營養衛教			
16-1 飲食宜忌	中醫師	100	根據 1 位專家的建議，將 16-1 至 16-2 合併為營養衛教
16-2 改善營養不良/過多	西醫師		
特殊飲食	護理師		
第九類呼吸照護			
17-1 拍痰	護理師	100	根據 3 位專家的建議，將 17-1 至 17-4 合併為呼吸照護
17-2 抽痰			
17-3 呼吸器照護			
17-4 蒸氣吸入照護			

表 4-4

第 1 回合-第二部分療護計畫與執行 專家意見及統計結果(N=24)

工作項目	由誰做	期望能做(%)	工作項目修改
第十類呼吸衛教			
18-1 拍痰	護理師	100	根據 3 位專家的建議，將 18-1 至 18-4 合併為呼吸照護衛教
18-2 抽痰			
18-3 呼吸器照護			
18-4 蒸氣吸入照護			
第十一類生活照護			
19-1 提供會福利資源相關資訊	護理師	100	根據 2 位專家的建議，將 19-1 至 19-4 合併為社區資源轉介
19-2 提供無障礙環境建議			
19-3 建議輔具選購			
19-4 提供喘息服務建議			
第十二類用藥指導			
20-1 藥物保存	中醫師	100	根據 2 位專家的建議，將 20-1 至 20-4 合併為用藥指導
20-2 用藥安全	西醫師		
20-3 藥物交互作用	護理師		
20-4 廢棄藥物處理			
第十三類評值			
21-1 評值照護成效	中醫師	100	根據 3 位專家的建議，將 21-1 至 21-3 合併為評值照護項目執行成效
	西醫師		
	護理師		
21-2 決定中醫結案	中醫師	100	
21-3 決定西醫結案	西醫師	100	

第三部分「團隊合作」，所有職類（西醫師、中醫師、護理師、呼吸治療師、藥師、社工師、復健師、營養師）對此部分的工作內容為 100%共識，無建議修改之項目，詳表 4-5。

綜合上述三部分，將專家意見整理歸納後進行修訂，根據德菲法中的共識標準達到 75%或以上的專家意見具有共識，可視為具有高度共識（Hasson et al., 2000），據此擬定設計出第二回合德菲法專家問卷。

表 4-5

第 1 回合-第三部分團隊合作專家意見及統計結果(N=24)

工作項目	由誰做	期望能做(%)	工作項目修改
第十一類團隊合作			
22-1 邀請其他職類參與居家照護	所有職類 (中醫師、西醫師、	100	
22-2 知道其他健康照護人員能提供甚麼照護	護理師、呼吸治療師、藥師、社工師、		
22-3 向 <u>同</u> 職類人員要求協助及建議	復健師、營養師)		
22-4 向 <u>其他</u> 職類要求協助及建議			
22-5 依個案狀況 <u>不定期</u> 與			
22-6 其他職類討論個案的療護計畫			
22-7 以 <u>電子</u> 表單與其他健康照護人員之溝通、協調、轉介			
22-8 回覆照顧個案之 <u>其他</u> 健康照護人員期望知道的個案狀況			
22-9 綜合各健康照護人員意見，決定與修改個案的療護計畫			

另彙整「各職類執行前需參閱之資料」(表 4-6 至 4-8)，各職類在收案與評估資料上具高度共識(收案紀錄、病史/用藥史、生命徵象、系統性評估、照護計畫皆為必備)。護理師對於「電刺激、推拿、針灸、穴位按壓、刮痧、拔罐」等中醫相關處置及衛教的資料需求介於 33%至 67%，其他資料需要的情形為 100%；西醫師對於「四診評估、電刺激、推拿、穴位按壓、刮痧、拔罐、翻身擺位、轉位、被動關節運動、身體活動照護、提供無障礙環境建議、建議輔具選購、提供喘息服務建議」等資料需求介為 50%，其他資料需要的情形為 100%；中醫師對於「留存的導管、居家生活、呼吸相關照護技巧、導管照護技巧、檢體採集、傷口照護、管路照護、翻身擺位、轉位、被動關節運動、身體活動照護、家用呼吸器照護、蒸氣吸入照護、營養調配、吞嚥功能訓練」等資料需求介於 50%至 75%，其餘結為 100%需要；營養師、社工師、呼吸治療師、復健師、藥師對於「收案評估、疾病史、用藥史、系統性回顧評估、意識狀況、營養狀況、評值照護項目執行成效、跨領域團隊合作」資料是 100%需要的，其他則依照各自的專業領域，有不同的資料需求。

表 4-6

各職類於進行居家照護時需參閱的資料-第一部分(N=24)

工作項目	各居家照護職類(%)							
	西 醫 師	中 醫 師	護 理 師	營 養 師	社 工 師	呼 吸 治 療 師	復 健 師	藥 師
決定居家收案	100	100	100	100	100	100	100	100
決定西醫收案	100	100	100	100	100	100	100	100
決定中醫收案	100	100	100	100	100	100	100	100
過去病史	100	100	100	100	100	100	100	100
現存疾病	100	100	100	100	100	100	100	100
過去用藥	100	100	100	100	50	100	67	100
現在用藥	100	100	100	100	50	100	67	100
多重用藥	100	100	100	100	50	100	67	100
系統性回顧評估	100	100	100	100	50	100	100	50
四診評估	50	100	100	0	0	0	0	0
意識狀況	100	100	100	100	100	100	100	50
營養狀況	100	75	100	100	100	100	100	50
吞嚥功能	100	100	100	100	50	100	100	50
呼吸照護	100	100	100	50	0	100	67	0
留存的導管	100	50	100	50	0	100	33	0
居家生活	100	50	100	0	100	100	67	0
呼吸相關照護技巧	100	50	100	0	0	100	33	0
導管照護技巧	100	50	100	0	0	0	0	0

表 4-7

各職類於進行居家照護時需參閱的資料-第二部分(N=24)

工作項目	各居家照護職類(%)							
	西 醫 師	中 醫 師	護 理 師	營 養 師	社 工 師	呼 吸 治 療 師	復 健 師	藥 師
擬定療護計畫	100	100	100	100	100	100	100	100
開立處方	100	100	100	100	100	100	100	100
檢體採集	100	75	100	50	0	100	33	50
傷口照護	100	50	100	50	50	0	33	50
熱療	50	100	100	0	0	0	33	0
電刺激	50	100	33	0	0	0	0	0
推拿	50	100	33	0	0	0	33	0
針灸	100	100	33	0	0	0	33	0
穴位按壓	50	100	33	0	0	0	0	0
刮痧	50	100	67	0	0	0	0	0
拔罐	50	100	67	0	0	0	0	0
管路照護	100	50	100	50	0	100	33	0
翻身擺位	50	50	100	0	0	0	100	0
轉位	50	50	100	0	0	0	100	0
被動關節運動	50	50	100	50	50	0	100	0
身體活動照護	50	50	100	50	50	0	100	0
家用呼吸器照護	100	50	100	50	50	100	67	50
蒸氣吸入照護	100	50	100	0	50	100	67	50
營養調配	100	50	100	100	0	0	67	0
吞嚥功能訓練	100	50	100	100	0	0	100	50
用藥指導	100	100	100	100	0	100	100	100
傷口照護衛教	100	50	100	50	0	0	33	50
熱療照護衛教	50	100	83	0	0	0	67	0
電刺激照護衛教	50	100	67	0	0	0	33	0
推拿照護衛教	50	100	67	0	0	0	100	0
針灸照護衛教	50	100	67	0	0	0	33	0
穴位按壓照護衛教	50	100	67	0	0	0	33	0
刮痧照護衛教	50	100	67	0	0	0	0	0
拔罐照護衛教	50	100	83	0	0	0	0	0
管路照護衛教	100	50	100	50	0	100	33	0
翻身擺位衛教	50	50	100	0	0	0	100	0
轉位衛教	50	50	100	0	0	0	100	0
被動關節運動衛教	50	50	100	0	0	0	100	0
身體活動照護衛教	50	50	100	0	0	0	100	0
家用呼吸器照護衛教	100	50	100	0	0	100	67	0
蒸氣吸入照護衛教	100	50	100	0	0	100	67	100
飲食宜忌衛教								
改善營養不良/改善營養 過多衛教	100	50	100	100	0	0	0	0
吞嚥功能訓練衛教	100	50	100	100	0	0	100	0
提供會福利資源相關資訊	100	50	100	100	100	100	33	0
提供無障礙環境建議	50	50	100	50	100	100	100	0
建議輔具選購	50	50	100	50	100	100	100	0
提供喘息服務建議								
評值照護項目執行成效	100	100	100	100	100	100	100	100

表 4-8

各職類於進行居家照護時需參閱的資料-第三部分(N=24)

工作項目	各居家照護職類(%)							
	西 醫 師	中 醫 師	護 理 師	營 養 師	社 工 師	呼 吸 治 療 師	復 健 師	藥 師
邀請其他職類參與居家照護	100	100	100	100	100	100	100	100
知道 <u>其他</u> 健康照護人員能提供甚麼照護	100	100	100	100	100	100	100	100
向 <u>同</u> 職類人員要求協助及建議	100	100	100	100	100	100	100	100
向 <u>其他</u> 職類要求協助及建議	100	100	100	100	100	100	100	100
依個案狀況 <u>不定期</u> 與其他職類討論個案的療護計畫	100	100	100	100	100	100	100	100
以 <u>電子表單</u> 與其他健康照護人員之 <u>溝通、協調、轉介</u>	100	100	100	100	100	100	100	100
回覆照顧個案之 <u>其他</u> 健康照護人員期望知道的個案狀況	100	100	100	100	100	100	100	100
綜合各健康照護人員意見，決定與修改個案的療護計畫	100	100	100	100	100	100	100	100

第三節 第二回合德菲法專家問卷研究結果

第二回合問卷共 110 題，經專家回饋後共修訂 7 題，其餘保留（見表 4-9 至表 4-11），並依「同意比例 $\geq 75\%$ 視為達成共識」的標準判斷。整體而言，多數題項均獲專家高度同意，各部分結果如下：

第一部分、居家評估收案與紀錄部分僅 1 題，內容為「居家照護收案評估、決定收案與紀錄」，此工作項目由西醫師、護理師、中醫師執行的同意占比為 96% 至 100%，均已達成共識門檻，予以完整保留。結果顯示，專家一致認為收案評估可由西醫師、護理師與中醫師進行收案。

第二部分、第一次案家訪視評估與紀錄部分共 16 題，多數題項同意占比介於 92% 至 100% 間，少數題目如「留置管路」、「輔具使用」及「社區資源轉介」等，中醫師同意比例僅 50% 至 67%。

第三部分、執行療護與紀錄部分 31 題，涵蓋中醫處置、一般處置、中醫指導與一般指導。其中「電刺激」（題 22）護理師同意占比僅有 50%，依照專家建議，改由中醫師主責；「管路照護衛教」（題 43）在西醫與中醫的同意占比僅 63% 與 50%，依照專家建議調整為護理師主責；「社區資源轉介」（題 46）中醫師的同意占比僅 50%，依照專家建議修訂為護理師負責，顯示不同專業在其核心職責上已形成明確分工。結果呈現各職類在居家照護中應擔任的職責與執行情境。

第四部分、其他職類參與居家照護僅 1 題，本題同意占比介於 88% 至 100%，顯示其他職類加入團隊的必要性。

第五部分、跨領域團隊合作包含 7 題，所有題項同意占比分布在 88% 至 100% 之間，這些結果呈現專家對合作的認知及共識。

表 4-9

第 2 回合專家意見及統計結果(N=24)

工作項目	由誰做	工作項目修改
第一部分居家評估收案與紀錄		
1. 居家照護收案評估、決定收案與紀錄	西醫師/(96%) 護理師/(100%) 中醫師/(96%)	
第二部分第一次案家訪視評估與紀錄		
2. 疾病史	西醫師/(100%) 護理師/(96%) 中醫師/(100%)	
3. 用藥史	西醫師/(100%) 護理師/(96%) 中醫師/(100%)	
4. 系統性回顧評估與紀錄 (含心血管、呼吸、腸胃、神經、淋巴、泌尿、皮膚、生殖、內分泌、肌肉骨骼等系統)	西醫師/(100%) 護理師/(92%) 中醫師/(92%)	
5. 四診評估(含望、聞、問、切)	中醫師/(100%)	
6. 意識狀況	西醫師/(100%) 護理師/(100%) 中醫師/(100%)	
7. 營養狀況	西醫師/(100%) 護理師/(100%) 中醫師/(96%)	
8. 吞嚥功能	西醫師/(96%) 護理師/(96%) 中醫師/(92%)	
9. 呼吸照護(含呼吸器；氧療)	西醫師/(96%) 護理師/(100%) 中醫師/(83%)	
10. 留置管路	西醫師/(92%) 護理師/(100%) 中醫師/(50%)	
11. 輔具使用(含輔具使用、無障礙環境)	西醫師/(83%) 護理師/(100%) 中醫師/(79%)	
12. 社區資源轉介(社福資源、喘息服務)	西醫師/(79%) 護理師/(100%) 中醫師/(67%)	
13. 呼吸照護技巧(含抽痰、拍痰)	西醫師/(79%) 護理師/(100%) 中醫師/(58%)	
14. 管路照護技巧	西醫師/(79%) 護理師/(100%) 中醫師/(58%)	
15. 擬定療護計畫	西醫師/(100%) 護理師/(92%) 中醫師/(100%)	
16. 開立醫囑	西醫師/(100%) 中醫師/(100%)	

表 4-10

第 2 回合專家意見及統計結果(N=24)

題項	工作項目	由誰做	工作項目修改
第三部分執行療護與紀錄			
中醫處置			
17.	推拿	中醫師/(100%)	
18.	針灸	中醫師/(100%)	
19.	刮痧	中醫師/(100%)	
20.	拔罐	中醫師/(100%)	
21.	熱療	中醫師/(100%)	
		護理師/(83%)	
22.	電刺激	中醫師/(100%)	
		護理師/(50%)	
23.	穴位按壓	中醫師/(100%)	
		護理師/(83%)	
一般處置			
24.	管路照護	護理師/(92%)	
25.	身體清潔與舒適照護	護理師/(96%)	
26.	吞嚥功能訓練	護理師/(92%)	
27.	呼吸照護(含呼吸器、氧療)	護理師/(92%)	
28.	檢體採集	西醫師/(96%)	
		護理師/(100%)	
29.	傷口照護	西醫師/(92%)	
		護理師/(100%)	
		中醫師/(88%)	
30.	營養照護	西醫師/(88%)	
		護理師/(100%)	
		中醫師/(100%)	
中醫指導			
31.	推拿照護衛教	中醫師/(100%)	
32.	熱療照護衛教	中醫師/(100%)	
		護理師/(83%)	
33.	電刺激照護衛教	中醫師/(100%)	
34.	針灸照護衛教	中醫師/(100%)	
		護理師/(83%)	
35.	穴位按壓照護衛教	中醫師/(100%)	
		護理師/(83%)	
36.	刮痧照護衛教	中醫師/(100%)	
		護理師/(79%)	
37.	拔罐照護衛教	中醫師/(100%)	
		護理師/(100%)	
一般指導			
38.	身體清潔與舒適照護衛教	護理師/(96%)	
39.	呼吸照護衛教	護理師/(100%)	
40.	吞嚥功能訓練衛教	護理師/(92%)	
41.	用藥衛教	西醫師/(92%)	
		護理師/(96%)	
		中醫師/(100%)	
42.	傷口照護衛教	西醫師/(100%)	
		護理師/(100%)	
		中醫師/(100%)	
43.	管路照護衛教	西醫師(63%)	
		護理師/(100%)	
		中醫師/(50%)	
44.	營養衛教	西醫師/(88%)	
		護理師/(88%)	
		中醫師/(100%)	
45.	輔具使用 (含輔具使用、無障礙環境)	西醫師/(79%)	
		護理師/(88%)	
		中醫師/(100%)	
46.	社區資源轉介 (社福資源、喘息服務)	西醫師/(75%)	
		護理師/(96%)	
		中醫師/(50%)	
47.	評值照護項目執行成效	西醫師/(100%)	
		護理師/(100%)	
		中醫師/(100%)	

表 4-11

第 2 回合專家意見及統計結果(N=24)

題項	工作項目	由誰做	工作項目修改
第四部分其他職類參與居家照			
48.	邀請其他職類參與居家照護	西醫師/(100%) 護理師/(96%) 中醫師/(88%)	
第五部分跨領域團隊合作			
49.	知道 <u>其他</u> 健康照護人員能提供甚麼照護	所有職類/(92%)	
50.	向 <u>同</u> 職類人員要求協助及建議	所有職類/(100%)	
51.	向 <u>其他</u> 職類要求協助及建議	所有職類/(100%)	
52.	依個案狀況 <u>不定期</u> 與其他職類討論個案的療護計畫	所有職類/(88%)	
53.	以 <u>電子表單</u> 與其他健康照護人員之 <u>溝通、協調、轉介</u>	所有職類/(100%)	
54.	回覆照顧個案之 <u>其他</u> 健康照護人員期望知道的個案狀況	所有職類/(88%)	
55.	綜合各健康照護人員意見，決定與修改個案的療護計畫	所有職類/(88%)	

第六部分：各職類進行居家照護需要參閱的資料，如表 4-12 至表 4-13。「居家照護收案評估、決定收案與紀錄」資料為所有職類所需。在「第一次案家訪視評估與紀錄」資料中，西醫師除四診評估資料不需要外，100%需要其他工作項目資料；除 75%的中醫師需要呼吸照護技巧及管路照護技巧資料，其他 100%需要其他工作項目資料；除 63%的護理師需要四診評估資料，其他 100%需要其他工作項目資料；營養師不需要四診評估資料，50%需要呼吸照護技巧及管路照護技巧資料，其他 100%需要其他工作項目資料；社工師不需要四診評估、呼吸照護技巧及管路照護技巧資料，其他 100%需要其他工作項目資料；呼吸治療師除四診評估資料不需要外，100%需要其他工作項目資料；復健師除四診評估資料不需要外，33%需要呼吸照護技巧及管路照護技巧資料，100%需要其他工作項目資料；藥師不需要四診評估、營養狀況、社區資源轉介、呼吸照護技巧、管路照護技巧資料，50%需要吞嚥功能、呼吸照護、留置管路、輔具使用資料，100%需要其他工作項目資料。在「執行療護與紀錄」中，西醫師不需要推拿照護衛教、熱療照護衛教、電刺激照護衛教資料，50%需要推拿資料，100%需要其他工作項目資料；中醫師 75%需要管路照護、身體清潔與舒適照護衛教、呼吸照護衛教、傷口照護衛教、管路照護衛教資料，100%需要其他工作項目資料；護理師 88%需要中醫處置、推拿照護衛教、熱療照護衛教、電刺激照護衛教資料，100%需要其他工作項目資料；營養師不需要中醫處置、中醫指導、管路照護衛教資料，50%需要身體清潔與舒適照護衛教、傷口照護、管路照護、身體清潔與舒適照護衛教、呼吸照護衛教、傷口照護衛教資料，100%需要其他工作項目資料；社工師不需要中醫處置、中醫指導、吞嚥功能訓練、傷口照護、管路照護、營養照護、管路照護衛教資料，50%需要檢體採集、傷口照護衛教資料，100%需要其他工作項目資料；呼吸治療師不需要中醫處置資料，100%需要其他工作項目資料；復健師不需要穴位按壓、刮痧、拔罐、拔罐照護衛教資料，67%需要推拿、針灸、熱療、電刺激、身體清潔與舒適照護衛教、推拿照護衛教、熱療照護衛教、電刺激照護衛

教、針灸照護衛教、穴位按壓照護衛教、刮痧照護衛教、身體清潔與舒適照護衛教、呼吸照護衛教、管路照護衛教資料，100%需要其他工作項目資料；藥師 50% 需要檢體採集、呼吸照護、吞嚥功能訓練衛教資料，100%需要用藥衛教及評值照護項目執行成效資料，不需要其他資料。在「其他職類參與居家照護」中，資料為所有職類所需。在「跨領域團隊合作會」中，資料為所有職類所需。

表 4-12

各職類需參閱資料的資料 (N=24)

工作項目	各居家照護職類參閱資料(%)							
	西 醫 師	中 醫 師	護 理 師	營 養 師	社 工 師	呼 吸 治 療 師	復 健 師	藥 師
1. 居家照護收案評估、決定收案與紀錄	100	100	100	100	100	100	100	100
1. 疾病史	100	100	100	100	100	100	100	100
2. 用藥史	100	100	100	100	100	100	100	100
3. 系統性回顧評估	100	100	100	100	100	100	100	100
4. 四診評估	0	100	63	0	0	0	0	0
5. 意識狀況	100	100	100	100	100	100	100	100
6. 營養狀況	100	100	100	100	100	100	100	0
7. 吞嚥功能	100	100	100	100	100	100	100	50
8. 呼吸照護	100	100	100	100	100	100	100	50
9. 留置管路	100	100	100	100	100	100	100	50
10. 輔具使用	100	100	100	100	100	100	100	50
11. 社區資源轉介	100	100	100	100	100	100	100	0
12. 呼吸照護技巧	100	75	100	50	0	100	33	0
13. 管路照護技巧	100	75	100	50	0	100	33	0
14. 擬定療護計畫	100	100	100	100	100	100	100	100
15. 開立處方	100	100	100	100	100	100	100	100
中醫處置								
16. 推拿	50	100	88	0	0	0	67	0
17. 針灸	100	100	88	0	0	0	67	0
18. 穴位按壓	100	100	88	0	0	0	0	0
19. 刮痧	100	100	88	0	0	0	0	0
20. 拔罐	100	100	88	0	0	0	0	0
21. 熱療	100	100	88	0	0	0	67	0
22. 電刺激	100	100	88	0	0	0	67	0
一般處置								
23. 檢體採集	100	100	100	100	50	100	100	50
24. 身體清潔與舒適照護衛教	100	100	100	50	100	100	67	0
25. 呼吸照護	100	100	100	100	100	100	100	50
26. 吞嚥功能訓練	100	100	100	100	0	100	100	0
27. 傷口照護	100	100	100	50	0	100	67	0
28. 管路照護	100	75	100	50	0	100	67	0
29. 營養照護	100	100	100	100	0	100	67	0
中醫指導								
30. 推拿照護衛教	0	100	88	0	0	100	67	0
31. 熱療照護衛教	0	100	88	0	0	100	67	0
32. 電刺激照護衛教	0	100	88	0	0	100	67	0
33. 針灸照護衛教	100	100	100	0	0	100	67	0
34. 穴位按壓照護衛教	100	100	100	0	0	100	67	0
35. 刮痧照護衛教	100	100	100	0	0	100	67	0
36. 拔罐照護衛教	100	100	100	0		100	0	0
一般指導								
37. 身體清潔與舒適照護衛教	100	75	100	50	100	100	67	0
38. 呼吸照護衛教	100	75	100	50	100	100	67	0
39. 吞嚥功能訓練衛教	100	100	100	100	100	100	100	50
40. 用藥衛教	100	100	100	100	100	100	100	100
41. 傷口照護衛教	100	75	100	50	50	100	100	0
42. 管路照護衛教	100	75	100	0	0	100	67	0
43. 營養衛教	100	100	100	100	100	100	100	0
44. 輔具使用衛教	100	100	100	50	100	100	100	0
45. 社區資源轉介衛教	100	100	100	50	100	100	100	0
46. 評值照護項目執行成效	100	100	100	100	100	100	100	100
47. 邀請其他職類參與居家照護	100	100	100	100	100	100	100	100

表 4-13

各職類需參閱資料的資料(N=24)

工作項目	各居家照護職類參閱資料(%)							
	西 醫 師	中 醫 師	護 理 師	營 養 師	社 工 師	呼 吸 治 療 師	復 健 師	藥 師
48. 知道 <u>其他</u> 健康照護人員能提供甚麼照護	100	100	100	100	100	100	100	100
49. 向 <u>同</u> 職類人員要求協助及建議	100	100	100	100	100	100	100	100
50. 向 <u>其他</u> 職類要求協助及建議	100	100	100	100	100	100	100	100
51. 依個案狀況 <u>不定期</u> 與其他職類討論個案的療護計畫	100	100	100	100	100	100	100	100
52. 以 <u>電子表單</u> 與其他健康照護人員之 <u>溝通、協調、轉</u>	100	100	100	100	100	100	100	100
53. 回覆照顧個案之 <u>其他</u> 健康照護人員期望知道的個案狀況	100	100	100	100	100	100	100	100
54. 綜合各健康照護人員意見，決定與修改個案的療護計畫	100	100	100	100	100	100	100	100

第四節 第三回合德菲法專家問卷研究結果

本研究依前兩回合結果，將第三回合分析分為兩個層次：第 1 至 3 部分聚焦西醫師、中醫師、護理師 (N=14)，第 4 及 5 部分擴納其他職類 (含呼吸治療師、藥師、營養師、社工師、復健師在內，共八職類；N=24)。各題之 Fleiss' Kappa 介於 0.714 至 1.000 依 Landis & Koch(1977)之分類標準，顯示專家意見已達明顯共識。穩定度介於 79.52%至 100%，顯示第三回合專家共識程度高且穩定，詳見表 4-14 至表 4-15。

在「居家評估收案與紀錄」部分，共計 1 項，西醫師、中醫師及護理師 (N=14) 填答結果，Kappa 值為 1.000，屬「高度共識」，穩定度 98.77%。

「第一次案家訪視評估與紀錄」部分，共計 15 項，醫師、中醫師及護理師 (N=14) 填答結果，Kappa 值介於 0.714 至 1.000，多數題目達高度或完全一致；穩定度則介於 85.71%至 99.79%，顯示專家對於首次訪視的工作項目已逐漸趨於穩定與一致。

「執行療護與紀錄」部分，共計 31 項，西醫師、中醫師及護理師 (N=14) 填答各項之 Kappa 值介於 0.731 至 1.000，已有明顯共識；穩定度範圍 79.52%至 100%，顯示專家對療護工作達成一致共識，且意見穩定。

「其他職類參與居家照護」部分，共計 1 項，由西醫師、護理師、中醫師 (N=12) 進行填答。果顯示 Kappa 值為 1.000，屬高度共識，穩定度 89.26%。

「跨領域團隊合作」部分，共計 7 項，由八職類專家 (N=24) 填答。結果顯示各題 Kappa 值均為 1.000，穩定度除 49 題為 98.58%外，其他題項為 100%，顯示專家對跨領域合作的角色與方式均達到完全一致的高度共識。

表 4-14

第三回合專家共識結果(N=14)

工作項目(職類)	統計分析		
	百分比(%)	Kappa	穩定度(%)
1. 居家照護收案評估、決定收案與紀錄 (西醫師、護理師、中醫師)	96	1	98.77
2. 疾病史(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	98.79
3. 用藥史(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	98.58
4. 系統性回顧評估與紀錄 (西醫師、護理師、中醫師)	96	1	98.31
6. 四診評估(中醫師)	96	1	96.00
7. 意識狀況(西醫師、護理師、中醫師)	96	1	96.00
8. 營養狀況(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	98.58
9. 吞嚥功能(西醫師、護理師、中醫師)	96	1	98.31
10. 呼吸照護(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	92.59
11. 留置管路(西醫師、護理師、中醫師)	96	1	99.79
12. 輔具使用(西醫師、護理師、中醫師)	100	0.714	85.71
13. 社區資源轉介(西醫師、護理師)	96	1	92.86
14. 呼吸照護技巧(西醫師、護理師)	100	0.714	88.39
15. 管路照護技巧(西醫師、護理師)	100	1	88.39
16. 擬定療護計畫(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	97.12
17. 開立醫囑(西醫師、中醫師)	100	1	98.79
中醫處置			
18. 推拿(中醫師)	100	1	100.00
19. 針灸(中醫師)	100	1	100.00
20. 刮痧(中醫師)	100	1	100.00
21. 拔罐(中醫師)	100	1	79.52
22. 熱療(中醫師、護理師)	100	1	100.00
23. 電刺激(中醫師)	100	1	95.62
24. 穴位按壓(中醫師、護理師)	100	1	100.00
一般處置			
25. 管路照護(護理師)	100	1	100.00
26. 身體清潔與舒適照護衛教(護理師)	100	1	100.00
27. 吞嚥功能訓練(護理師)	100	1	100.00
28. 呼吸照護(護理師)	100	1	100.00
28. 檢體採集(西醫師、護理師)	100	1	91.30
29. 傷口照護(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	97.96
30. 營養照護(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	83.86
中醫指導			
31. 推拿照護衛教(中醫師)	100	1	95.62
32. 熱療照護衛教(中醫師、護理師)	100	1	91.30
33. 電刺激照護衛教(中醫師)	100	1	88.89
34. 針灸照護衛教(中醫師、護理師)	100	1	95.83
35. 穴位按壓照護衛教(中醫師、護理師)	100	1	93.62
36. 刮痧照護衛教(中醫師、護理師)	92	0.731	97.78
37. 拔罐照護衛教(中醫師、護理師)	100	1	88.89
一般指導			
38. 身體清潔與舒適照護衛教(護理師)	100	1	100.00
39. 呼吸照護衛教(護理師)	100	1	95.83
40. 吞嚥功能訓練衛教(護理師)	100	1	100.00
41. 用藥衛教(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	91.30
42. 傷口照護衛教(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	91.30
43. 管路照護衛教(護理師)	100	1	97.96
44. 營養衛教(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	87.51
45. 輔具使用(西醫師、護理師、中醫師)	100	1	86.36
46. 社區資源轉介(西醫師、護理師)	100	1	87.51
48. 邀請其他職類參與居家照護 (西醫師、護理師、中醫師)	100	1	89.26

表 4-15

第三回合專家共識結果(N=14)

工作項目(職類)	統計分析		
	百分比(%)	Kappa	穩定度(%)
49. 知道其他健康照護人員能提供甚麼照護(所有職類)	100	1	98.58
50. 向同職類人員要求協助及建議(所有職類)	100	1	100.00
51. 向其他職類要求協助及建議(所有職類)	100	1	100.00
52. 依個案狀況不定期與其他職類討論個案的療護計畫(所有職類)	100	1	100.00
53. 以電子表單與其他健康照護人員之溝通、協調、轉介(所有職類)	100	1	100.00
54. 回覆照顧個案之其他健康照護人員期望知道的個案狀況(所有職類)	100	1	100.00
55. 綜合各健康照護人員意見，決定與修改個案的療護計畫(所有職類)	100	1	100.00

在「各職類進行居家照護需要參閱的資料」部分(表 4-16 至表 4-17)，共計 55 項，由八職類專家(N=24)填答。此部分屬於專家需求性調查，未進行 Kappa 與穩定度分析，僅呈現專家對各類資料的需求，反映實務照護中臨床資訊共享的必要性。

「居家評估收案與紀錄」資料為所有職類所需。第一次案家訪視評估與紀錄中，疾病史、藥史、系統性回顧評估與紀錄、意識狀況、吞嚥功能、呼吸照護、留置管路、輔具使用、擬定療護計畫、開立醫囑資料為所有職類所需；四診評估資料為中醫師及護理師所需；營養狀況資料為中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師所需；社區資源轉介及呼吸照護技巧資料為中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師所需。

執行療護與紀錄中，檢體採集、吞嚥功能訓練衛教、用藥衛教、評值照護項目執行成效資料為所有職類所需；中醫處置資料多為護理師、中醫師、西醫師所需；一般處置資料多為中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、營養師所需；中醫指導為復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師所需；一般指導為中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師所需；「其他職類參與居家照護」資料為所有職類所需；「跨領域團隊合作會議」資料為所有職類所需。

表 4-16

各職類於參與居家照護需取得資料情形

工作項目	需要的職類
<i>居家評估收案與紀錄</i>	
56. 居家照護收案評估、決定收案與紀錄	所有職類
<i>第一次案家訪視評估與紀錄</i>	
57. 疾病史	所有職類
58. 用藥史	所有職類
59. 系統性回顧評估與紀錄	所有職類
60. 四診評估	護理師、中醫師
61. 意識狀況	所有職類
62. 營養狀況	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
63. 吞嚥功能	所有職類
64. 呼吸照護	所有職類
65. 留置管路	所有職類
66. 輔具使用	所有職類
67. 社區資源轉介	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
68. 呼吸照護技巧	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
69. 管路照護技巧	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、營養師
70. 擬定療護計畫	所有職類
71. 開立醫囑	所有職類
<i>執行療護與紀錄</i>	
<i>中醫處置</i>	
72. 推拿	西醫師、復健師、護理師、中醫師
73. 針灸	復健師、護理師、中醫師、西醫師
74. 穴位按壓	護理師、中醫師、西醫師
75. 刮痧	護理師、中醫師、西醫師
76. 拔罐	護理師、中醫師、西醫師
77. 熱療	護理師、中醫師、西醫師、復健師
78. 電刺激	護理師、中醫師、西醫師
<i>一般處置</i>	
79. 檢體採集	所有職類
80. 身體清潔與舒適照護衛教	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
81. 呼吸照護	所有職類
82. 吞嚥功能訓練	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、營養師
83. 傷口照護	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、營養師
84. 管路照護	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、營養師
85. 營養照護	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、營養師
<i>中醫指導</i>	
86. 推拿照護衛教	復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師
87. 熱療照護衛教	復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師
88. 電刺激照護衛教	復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師
89. 針灸照護衛教	復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師
90. 穴位按壓照護衛教	復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師
91. 刮痧照護衛教	復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師
92. 拔罐照護衛教	復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師
<i>一般指導</i>	
93. 身體清潔與舒適照護衛教	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
94. 呼吸照護衛教	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
95. 吞嚥功能訓練衛教	所有職類
96. 用藥衛教	所有職類
97. 傷口照護衛教	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
98. 管路照護衛教	復健師、護理師、中醫師、呼吸治療師
99. 營養衛教	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
100. 輔具使用(含輔具使用、無障礙環境)	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
101. 社區資源轉介(社福資源、喘息服務)	中醫師、西醫師、護理師、呼吸治療師、復健師、社工師、營養師
102. 評值照護項目執行成效	所有職類
<i>其他職類參與居家照護</i>	
103. 邀請其他職類參與居家照護	所有職類

表 4-17

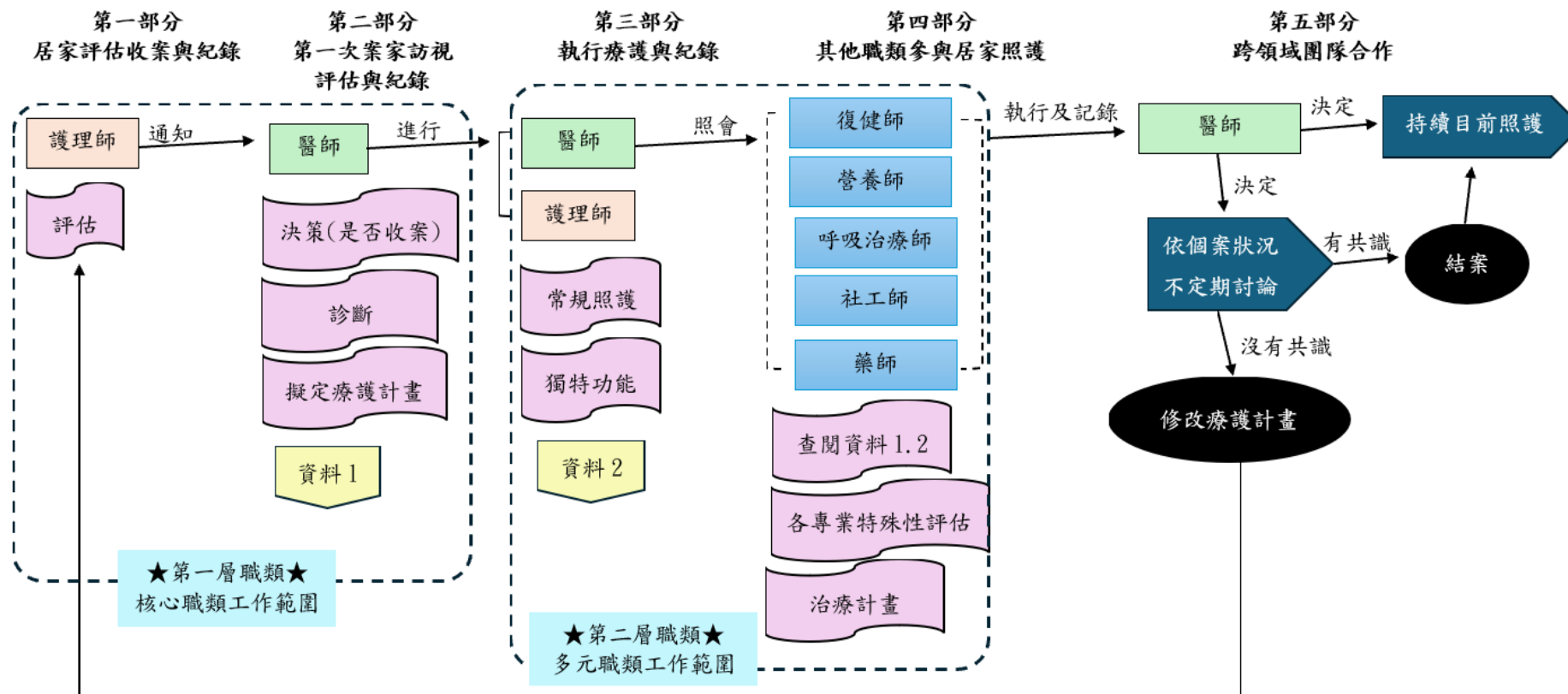
各職類於參與居家照護需取得資料情形-

工作項目	需要的職類
跨領域團隊合作會議	
104. 知道 <u>其他</u> 健康照護人員能提供甚麼照護	所有職類
105. 向 <u>同</u> 職類人員要求協助及建議	所有職類
106. 向 <u>其他</u> 職類要求協助及建議	所有職類
107. 依個案狀況 <u>不定期</u> 與其他職類討論個案的療護計畫	所有職類
108. 以 <u>電子表單</u> 與其他健康照護人員之溝通、協調、轉介	所有職類
109. 回覆照顧個案之 <u>其他</u> 健康照護人員期望知道的個案狀況	所有職類
110. 綜合各健康照護人員意見，決定與修改個案的療護計畫	所有職類

根據專家共識出的結果，繪製中西醫居家照護流程圖如圖 4-1，此圖分為五個部分，並透過不同顏色框框、箭頭與線條，呈現照護過程中，包含的職類、工作內容及資料呈現，長方形的框為各職類人員，其中護理師在長方形的框內底色為橘色、醫師在長方形的框內底色為綠色、其他職類（復健師、營養師、呼吸治療師、社工師及藥師）在長方形的框內底色為藍色、波浪形框為工作內容、向下箭頭型底色黃的為資料記錄、右箭頭形底色為藍的是行動節點、橢圓黑底的為決策點，箭頭為步驟、虛線框為合作層級。流程如下：第一部分居家評估收案與紀錄，由護理師進行居家照護收案評估後，由醫師決定是否收案。第二部分第一次案家訪視評估與紀錄，醫師決定收案後，會進行診斷、擬定療護計畫，此部分為第一層的合作關係。第三部分執行療護與紀錄由護理師、西醫師、中醫師進行常規照護，以及特殊性照護，並於完成工作後以電子系統進行紀錄。第四部分其他職類參與居家照護，由醫師視個案狀況會診其他職類（復健師、營養師、社工師、呼吸治療師、藥師），參與個案療護，此部分進入第二層的合作關係。第五部分跨領域團隊合作，當其他職類加入居家照護後，執行過程包含：查閱個案、進行各專業特殊性評估、進行治療計畫，並於執行後產生紀錄，再由醫師判斷，持續目前照護，或是安排討論會，如有達成共識，由醫師決定結案，沒有達成共識則修改療護計畫，重新回到第一部分的評估。

圖 4-1

中西醫居家照護流程圖



第五章 討論

本研究運用三回合德菲法，問卷內容的 Fleiss' Kappa 值落於 0.714 至 1 之間，顯示專家間具有高度共識。針對中西醫居家照護過程中，各職類之合作關係、啟動時機與溝通方式進行探討。

一、中西醫居家照護包含的職類

本研究結果顯示，中西醫居家照護流程依不同階段包含不同職類，第一部分為居家評估收案與紀錄，第二部分為第一次案家訪視評估與紀錄，第三部分為執行療護與紀錄，第四部分則為其他職類參與居家照護，於前四部分主要由護理師、西醫師與中醫師三個職類參與；第五部分跨領域團隊合作，則進一步擴展為護理師、西醫師、中醫師、藥師、營養師、社工師、復健師及呼吸治療師等八大職類。此結果與衛生福利部公告之《112 年全民健康保險居家醫療照護整合計畫》所規範的居家照護訪視人員相符。

在文獻比較方面，Stans et al. (2013)、Reeves et al. (2017)、Larsson et al. (2022) 及 Rusli et al. (2023) 所回顧之居家照護相關文獻，多半提及護士、醫師、藥師、營養師、社工人員、物理治療師與職能治療師等職類，較少涉及呼吸治療師，亦未涵蓋中醫師之角色。相較之下，本研究探討將中醫師與呼吸治療師納入職類架構。

此外，本研究不僅呈現職類在不同階段的差異性需求，依職類的工作內容，可區分為「第一層核心職類」與「第二層多元職類」兩的層次，為本研究之重要發現。

二、各職類於中西醫居家照護角色職責與工作內容

本研究中西醫居家照護中，護理師負責居家收案評估，通知醫師，作為是否收案與後續醫療計畫的依據、主要負責常規照護、獨特功能護理及衛教諮詢行為，具備獨立判斷與操作的能力，完成電子系統紀錄。醫師（中醫師、西醫師）進行診斷、制定療護計畫後，視個案需求照會其他職類加入居家照護，決定持續目前照護，或進行跨團隊討論會。

(一) 護理師

本研究結果顯示，護理師在居家照護流程中，扮演收案與健康評估的角色，進行個案健康狀態判斷、紀錄，主動通知醫師，作為後續醫療計畫的依據。此外，護理師也負責常規照護、專業護理技術操作、衛教諮詢工作，並完成電子系統紀錄，展現獨立判斷與臨床操作能力等。與《護理人員法》第 24 條第 1 項：「健康問題之護理評估」、「預防保健之護理措施」、「護理指導及諮詢」以及「醫療輔助行為」均屬護理師法定業務範疇，第 24 條第 2 項明文規定「醫療輔助行為」須在醫師指示下進行、第 26 條規定，護理人員於病人危急時應立刻通知醫師，但必要時得先行施行緊急救護處理相同。在居家照護實務中，護理師還需於醫師尚未介入時，先行獨立完成初步判斷與即時處置。尤其在緊急狀況下，這些工作已超出一般醫院內護理範疇。與醫院體系比較，病房護理師在特定專科病房中，職責與流程明確，能即時獲得醫師或同儕支援；門診護理師則多以衛教、流程協助與診間支持為主(Brenne et al., 2022)，居家護理師須獨自面對資訊不足、支援有限的挑戰，需具備更高的臨床敏銳性與獨立性，此一差異顯示居家護理工作已不僅限於《護理人員法》授權範圍。Stans et al. (2013)、Reeves et al. (2017) 的研究均指出，居家護理師在其他國家主要負責基本照護、健康教育與跨專業溝通，而較少涉及獨立決策或急性處置。

綜合以上，我國居家護理師不僅符合《護理人員法》授權，亦因臨床需求而承擔跨越法規界線的責任，凸顯制度與臨床實務間的落差，也是本研究的重要發現。

(二) 西醫師

在本研究結果中，西醫師主要負責診斷病情、制定療護計畫，並根據個案需求開立藥品處方或進行轉介。這些項目與《醫師法》第 11 條規定，醫師施行治療、開立處方或交付診斷書，原則上應親自診察，除非處於偏遠、特殊或緊急情況且獲主管機關指定，方得透過通訊方式進行處理、《醫師法》第 12 條，醫師在執業時需製作病歷並簽名或蓋章，註明執行日期；病歷內容至少應記載就診日期、主訴、檢查結果、診斷、治療或用

藥記錄、《醫師法》第 12-1 條明定，醫師診治病人時，應向病人或家屬告知病情、治療方針、處置方式、用藥與預後情形及可能之不良反應、《醫師法》第 21 條之規定，醫師遇有危急病人，應即依其專業能力進行救治或採取必要措施，不得無故延誤之責任相同。與醫院體系相比，西醫師在門診情境中，醫師主要依賴個人臨床判斷與基礎檢驗完成診斷與處方；住院情境中，能依靠完整檢驗數據、影像檢查及專科會診資源，並領導跨專業團隊進行決策，擁有多方的資源；在居家照護環境中，西醫師需依賴護理師提供的評估與紀錄，於有限的現場資源下進行臨床判斷。此種情境下，西醫師的決策常仰賴團隊間的跨專業溝通與資訊傳遞，與醫院模式有明顯不同。Stans et al. (2013)、Reeves et al. (2017) 指出，居家照護中的醫師多負責慢性病追蹤、藥物管理與照護計畫擬定，但多為獨立作業，與其他職類合作的連結有限。Larsson et al. (2022) 亦強調，部分歐洲居家醫療以全科醫師為主體，合作模式較簡化，可能與西方國家醫療分科制度有關。

(三) 中醫師

研究結果界定的中醫師的角色主要包括進行診斷、針灸治療、中藥處方與中醫傷科照護，並需與西醫師共同討論治療計畫，與《醫師法》第 11 條規定，醫師施行治療、開立處方或交付診斷書，原則上應親自診察，除非處於偏遠、特殊或緊急情況且獲主管機關指定，方得透過通訊方式進行處理、《醫師法》第 12 條，醫師在執業時需製作病歷並簽名或蓋章，註明執行日期；病歷內容至少應記載就診日期、主訴、檢查結果、診斷、治療或用藥記錄、《醫師法》第 12-1 條明定，醫師診治病人時，應向病人或家屬告知病情、治療方針、處置方式、用藥與預後情形及可能之不良反應、《醫師法》第 21 條之規定，醫師遇有危急病人，應即依其專業能力進行救治或採取必要措施，不得無故延誤之責任相同。與醫院體系相比，中醫師在醫院或診所的工作多以獨立門診為主，患者通常透過掛號或轉診單獨接受治療，跨專業合作的情況較少。在居家照護中，中醫師必須融入跨團隊合作，與西醫師及護理師合作，與傳統中醫師的工作職責不同。此部分可能與 2019 年起衛福部辦理之「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」將中醫師正式加入計

畫並給予給付有關。

(四) 藥師

本研究結果未討論到藥師的工作職責；根據《藥師法》第 11 條規定規範藥師的業務範圍包括藥品調劑、藥事照護、用藥指導及藥物管理之職責，本研究對於藥師的工作範疇與現行法規所賦予的職責存在差異。在醫院體系中，藥師多在藥局或病房內協助醫師與護理師，偏向幕後支持；不同之處在於居家照護中，藥師需直接面對病人與家屬，更貼近臨床。文獻提到藥師在居家照護團隊中多以用藥監測與病人教育為核心 (Reeves et al., 2017)。本研究未詳細探討藥師之工作職責，可能原因為第一回合的問卷沒有對藥師的實際工作項目進行彙整，導致專家無法在此部分進行共識。

(五) 營養師

本研究結果未討論到營養師的工作職責；根據《營養師法》第 2 條規定營養師業務包括營養評估、飲食設計、營養教育與營養照護。在醫院體系中，營養師多依醫師會診或病房需求進入照護；但在居家照護中，營養師需根據病人實際飲食環境與家庭支持系統設計方案，更貼近病人日常生活。文獻指出，營養師在居家照護的角色多著重於慢性病飲食管理與高齡營養支持 (Larsson et al., 2022)。本研究未詳細探討營養師之工作職責，可能原因為第一回合的問卷沒有對營養師的實際工作項目進行彙整，導致專家無法在此部分進行共識。

(六) 社工師

本研究結果未討論到社工師的工作職責；根據《社會工作師法》第 2 條規範的業務範圍包括評估與規劃社會工作服務，以及推動社會福利政策。在醫院體系中，社工師多於出院準備或特殊需求時介入；在居家照護中，社工師需長期追蹤個案，處理家庭、經濟及社會聯繫問題，而文獻顯示，社工多著重於資源轉介與心理支持 (Reeves et al., 2017)，本研究未詳細探討社工師之工作職責，可能原因為第一回合的問卷沒有對社工師的實際工作項目進行彙整，導致專家無法在此部分進行共識。

(七) 復健師

本研究結果未討論到復健師的工作職責；根據《物理治療師法》第2條與《職能治療師法》第2條，其業務範圍包括物理治療、運動訓練、職能訓練與作業治療，並提供輔具使用與生活環境改善建議。在醫院中，復健師常於治療室內進行訓練；在居家照護中，則需直接進入病人生活場域，提供個別化訓練與功能性改善。本研究未詳細探討復健師之工作職責，可能原因為第一回合的問卷沒有對復健師的實際工作項目進行彙整，導致專家無法在此部分進行共識。

(八) 呼吸治療師

本研究結果未討論到呼吸治療師的工作職責，根據《呼吸治療師法》第2條，呼吸治療師之業務範圍包括呼吸功能評估、氧氣治療、人工呼吸器操作與照護，以及協助醫師執行相關檢查與治療。在醫院體系中，呼吸治療師多於加護病房或急性病房中介入，偏向高強度治療；在居家照護中，則需長期協助病人維持呼吸功能，並教育家屬正確使用呼吸器與氧氣治療，角色更著重於長期支持；文獻較少提及呼吸治療師在居家照護中的角色。本研究未詳細探討呼吸治療師之工作職責，可能原因為第一回合的問卷沒有對呼吸治療師的實際工作項目進行彙整，導致專家無法在此部分進行共識。

一、各職類於中西醫居家照護合作的關係

本研究分成五個部份，分別為居家評估收案與紀錄、第一次案家訪視評估與紀錄、執行療護與紀錄、其他職類參與居家照護、跨領域團隊合作。

經歸納與共識，護理師為啟動居家照護的第一角色，進行收案評估，啟動整個照護流程，醫師（中醫或西醫）決定收案後，進行診斷及擬定療護計畫，此部分構成第一層的合作關係。再由護理師、西醫師、中醫師進行常規及特殊性照護，於完成工作後以電子系統進行紀錄；依個案需求由醫師會診其他職類（復健師、營養師、社工師、呼吸治療師、藥師），展開後續照護行動，由此部分進入第二層的合作關係；再由醫師視情況進行跨團隊討論會議，討論持續或修改療護計畫。

根據我國醫策會規範，自 2013 年起跨領域團隊合作被正式納入醫院評鑑，2017 年更進一步要求即時溝通與跨職類訓練。此規範與本研究理念一致，但臨床落實仍受資訊平台不足所限。根據研究中，專家們期望能透過電子資訊系統，取得跨領域團隊成員對於個案的照護的資料，所以應將資訊相關人員納入跨團隊中，發展即時互動資訊系統，如此一來，可以彌補資訊上的落差、溝通上的嫌隙，以縮短規範與實務落差。Stans et al. (2013) 在荷蘭初級照護體系中，同樣提出跨專業合作模式，將照護歷程分為登記、評估、治療與結案評估四個步驟，強調不同專業在照護歷程中同步合作與資訊共享，與本研究相比，兩者皆著重於分階段推進、多職類合作、資訊共享，此為共同之處。而 Stans 模式未納入中醫師與呼吸治療師角色，職類組成較偏向西方醫療體系常見配置，顯示出東西方醫療體系的差異。

二、構成中西醫居家照護模式的要素

本研究提出完善中西醫居家照護需要參與的職類、醫護的職責、工作內容與合作關係。職類分為核心與多元兩層，必須需參與的核心職類為中西醫師、護理師；依個案狀況加入的多元專業包括營養師、呼吸治療師、社工師、藥師等。工作流程從收案評估、居家訪視、療護執行到跨團隊合作及結案，涉及的醫護職類工作項目、角色職責，並討論透過資訊系統進行溝通互動。Rossetto et al. (2020) 於巴西針對特殊健康需求兒童提出居家照護流程，涵蓋出院轉介、資格評估、照顧者訓練、入宅照護及持續追蹤，並納入急性事件的應對機制。Stans et al. (2013) 在荷蘭則針對兒童發展問題提出登記/首次接觸、檢查/評估、治療、追蹤四個階段的合作流程。Sterling et al. (2020) 在美國則針對心臟衰竭患者設計流程，包含醫院轉銜、辨識臨床變化、決策、症狀管理、尋求協助及緊急處理。此類共同強調跨專業合作，而與本研究相異之處在於本研究尚缺危急應變機制。

三、研究方法

本研究在「職類於參與居家照護需取得資料情形」僅針對不同職類於居家照護過程

中所需參考之資料進行描述性統計分析，未進行 Kappa 值與穩定度等統計，與部分德菲法文獻中強調透過一致性分析來驗證信度之作法不同(Hasson, 2000; Linderman, 1975)。

第六章 結論、限制與建議

第一節 結論

本研究採德菲法探討中西醫居家照護，透過三回合問卷取得專家共識。研究結果顯示，多數項目 Fleiss' Kappa 值介於 0.714 至 1 之間，說明專家群對於問卷題項已達成共識。研究結果呈現出中西醫居家照護過程中，各職類參與的情形、角色職責及跨領域照護過程，並提出符合臺灣醫療體制的中西醫居家照護流程圖。

本研究結果顯示居家照護的職類共計八類，包含護理師、西醫師、中醫師、藥師、營養師、社工師、復健師及呼吸治療師，與我國《全民健康保險居家醫療照護整合計畫》規範及醫事人員相關法相符；然而臨床實務中，護理師經常因應個案狀況超越法規賦予的界線，需先行判斷與介入，再回報醫師補充決策，這顯示居家照護情境中，規範與實務可能存在落差。在居家照護中的合作關係，並非始於療護中段或僅在跨領域階段才出現，而是自收案評估即啟動並持續於各階段，本研究將各職類進一步劃分為核心職類與多元職類兩層次，核心職類負責流程啟動與醫療決策，多元職類則依個案狀況彈性加入，提升了彈性與合作的清晰度。

在如此多元且跨領域合作的居家照護環境中，在臨床實務上資訊整合與溝通平台成了迫切的需求，而目前電子平台多屬單向紀錄，難以即時互動，但若能在政策與技術上納入資訊人員，並建立跨專業資訊共享平台，將有助於提升照護的連續性與整合性。

第二節 限制與建議

在德菲法的執行過程中，第一回合問卷的結構相對鬆散，未對非醫護職類（如營養師、社工師、復健師）之實際工作項目彙整資料列出，導致專家第一回合回饋費時，獲得許多書面建議，資料回收後耗費相當多的時間進行整理與歸納；使得第二回合問卷在

結構與內容上與第一回合出現明顯的差異。使得本研究對於非醫護領域專業人員的職責功能的描述不夠詳盡，可能影響專業職責呈現上的完整性。

本研究專家樣本主要為東台灣區域之中西醫、護理及其他照護相關領域專家，專家來源以醫學中心為主，未涵蓋偏鄉、診所或長照機構等場域，可能導致研究結果侷限於慈濟體系的觀點，影響其他醫療體系的適用性。

另一方面，在「參與居家照護需取得資料之情形」的需求性調查中，本研究僅以百分比統計呈現專家需求，並未進一步進行 Kappa 值與穩定度分析，缺乏統計一致性驗證的支持，屬本研究方法上的不足之處。

根據本研究結果提出以下建議：

- 一、在研究方法上，建議後續研究能於第一回合即建構更具結構化的問卷，以減少回合間的差異，在資料處理上，非醫護職類的工作項目應蒐集更廣泛且具體的意見，並查閱相關法規、實務案例及國際文獻。在資料處理上，「參與居家照護需取得資料之情形」應更進一步的確認專家意見的共識及穩定性。
- 二、在政策層面，建議主管機關於推動居家醫療相關政策時，應將中西醫居家照護流程納入考量，將跨專業合作與資訊平台納入居家醫療評鑑指標，建置完善的電子資訊系統，使溝通合作上沒有落差。
- 三、在醫院與機構實務層面，本研究結果可供各院參考，修訂或制定院內跨專業合作規範，並發展標準作業流程，強化跨專業的即時溝通，將資訊人員納入合作架構，確保臨床資訊能即時交換與回饋，進一步提升照護的連續性與效率。
- 四、最後，在學術研究層面，建議未來可將本研究延伸，針對本研究未仔細描述的職類進行探討，並進行跨國比較，檢視此流程在不同醫療體系下的可行性。

參考文獻

中文部分

中華民國法務部（2023）．呼吸治療師法．全國法規資料庫。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020180>

中華民國法務部（2023）．物理治療師法．全國法規資料庫。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020178>

中華民國法務部（2023）．社會工作師法．全國法規資料庫。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020066>

中華民國法務部（2023）．營養師法．全國法規資料庫。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020042>

中華民國法務部（2023）．職能治療師法．全國法規資料庫。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020179>

中華民國法務部（2023）．醫師法．全國法規資料庫。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020001>

中華民國法務部（2023）．藥師法．全國法規資料庫。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020007>

中華民國法務部（2023）．護理人員法．全國法規資料庫。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020166>

白惠文、安欣瑜、林玉琴、張珮綺、李雅卿、姚維仁、陳煒（2019）．醫院與居家醫療照護整合計劃－嘉基經驗．醫院雜誌，52(1)，68-75。

[https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20190424001-201903-](https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20190424001-201903-201904240015-201904240015-68-75)

[201904240015-201904240015-68-75](https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20190424001-201903-201904240015-201904240015-68-75)

吳孟嬪、馮容莊、黃美齡、何璇、孫文榮、黃勝堅（2019）．建構完善的台北市居家

安寧照護模式・北市醫學雜誌，16，134-144。

https://doi.org/10.6200/TCMJ.201910/SP_16.0014

宋文娟（2001）・一種質量並重的研究法—德菲法在醫務管理學研究領域之應用・醫務管理期刊，2(2)，11-20。[https://doi.org/10.6174/JHM2001.2\(2\).11](https://doi.org/10.6174/JHM2001.2(2).11)

李佳倫、洪志秀（2017）・推動跨領域團隊教育的挑戰和策略・護理雜誌，64(6)，106-111。<https://doi.org/10.6224/JN.000089>

林能傑（2011）・漫談現代醫學的發展・臺灣醫界，54(2)，109-113。
<https://doi.org/10.30044/TMJ.201102.0009>

施秀樺、黃采薇（2021）・從國內居家整合照護計畫探討安寧緩和整合照護模式新契機・腫瘤護理雜誌，21(1)，5-17。[https://doi.org/10.6880/TJON.202106_21\(1\).01](https://doi.org/10.6880/TJON.202106_21(1).01)

紀淑靜、葉莉莉、盧美秀、林珮宇（2015）・運用德菲法建構腦中風急性後期照顧護理人員應具備之核心能力・護理雜誌，62(6)，35-47。<https://doi.org/10.6224/JN.62.6.35>

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（2017）・醫院評鑑及教學醫院評鑑。取自
<https://www.jct.org.tw/lp-1156-1-xCat-05.html>

財團法人醫院暨醫療品質策進會（2019）・108年度醫院評鑑基準（區域醫院、地區醫院適用）。引自<https://www.jct.org.tw/lp-1156-1-xCat-01.html>

國家發展委員會（2020）・中華民國人口推估（2020至2070年）。國家發展委員會。取自

[https://popproj.ndc.gov.tw/upload/download/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%8E%A8%E4%BC%B0\(2020%E8%87%B32070%E5%B9%B4\)%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf](https://popproj.ndc.gov.tw/upload/download/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%8E%A8%E4%BC%B0(2020%E8%87%B32070%E5%B9%B4)%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf)

許靜文、李璧伊、湯振青、陳思豪（2018）・談出院準備服務・家庭醫學與基層醫療，33（10），285-289。<https://doi.org/10.6965/FMPMC>

陳品璇、曾育慧、許中華（2022）・中醫居家醫療之現況與展望・台灣公共衛生雜

- 誌，41(1)，16-35。https://doi.org/10.6288/TJPH.202202_41(1).110130
- 陳嘉允、李亞倫（2020）。稻田裡的故事，全人照顧的中醫居家醫療。彰基院訊，37(11)，14-15。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P2014
- 陳麗麗、王純娟、林君黛、張曼玲（2011）。實用中醫護理學（一版）。華杏。URL: www.farseeing.com.tw
- 黃奎祐、葉裕祥、謝惠婷、李育賢、黃伯瑜、許中華（2018）。居家醫療整合照護之中醫經驗與展望。中醫藥研究論叢，21(2)，245-254。
https://doi.org/10.6516/TJTCM.201809_21(2).0021
- 黃頌儼（2019）。建構全方位之中醫及中西醫整合醫療中心。彰基院訊，36(7)，4-5。
https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20140814001-201907-201908080016-201908080016-4-5
- 慈濟全球慈網（2021 年）。慈濟醫療體系概況。慈濟全球慈網。取自: http://www.tzuchi.com.tw/CSR/home/index.php/2019-01-19-07-47-57
- 衛生福利部（2010 年）。全民健保總額支付制度 99 年度。
https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=F82BF64A82FD5908&topn=5FE8C9FEAE863B46
- 衛生福利部（2015 年 4 月 23 日）。104 年全民健康保險居家醫療整合照護試辦計畫。
https://site.jah.org.tw/pha/pha_web/c01_news/c01_pdf/h_news104/h1040004024.pdf
- 衛生福利部（2016 年 7 月 3 日）。行政長期照顧十年計劃 2.0（106~115 年）核定本。
https://1966.gov.tw/LTC/cp-4001-42414-201.html
- 衛生福利部中央健康保險署（2023）。112 年全民健康保險居家醫療照護整合計畫（1120322 公告版）。https://www.nhi.gov.tw/

英文部分

- Baggs, J. G., & Schmitt, M. H. (1988). Collaboration between nurses and physicians. *Image J Nurs Sch*, 20(3), 145-149. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1988>.
- Brenne, B. A., Hedlund, M., & Ingstad, K. (2022). Exploring home-based care nurses' mindset for nursing practices: A phenomenological study. *BMC Nursing*, 21, Article 291. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-01068-w> CD000072.pub2
- Hasson, F., Keeney, S., & McKenna, H. (2000). Research guidelines for the Delphi survey technique. *Journal of Advanced Nursing*, 32(4), 1008-1015.
- Jon Landeta (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. *Technological Forecasting & Social Change*, 73(5), 467-482. doi:10.1016/j.techfore.
- IBM Corp. (2019). *IBM SPSS statistics base (Version 26) [Computer software]*. IBM. https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_26.0.0/pdf/zh/CN/IBM_SPSS_Statistics_Base.pdf
- Judith G. Baggs; Madeline H. Schmitt (1988). Collaboration Between Nurses and Physicians. *journal of nursing scholarship*, 20(3), 145–149. doi:10.1111/j.1547-5069.1988.tb00055.x
- Keeney, S., Hasson, F., & McKenna, H. (2011). *The Delphi Technique in Nursing and Health Research*. doi:10.1002/9781444392029
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174. <https://doi.org/10.2307/2529310>
- Larsson, R., Erlingsdóttir, G., Persson, J., & Rydenfält, C. (2022). Teamwork in home care nursing: A scoping literature review. *Health & Social Care in the Community*, 30(6), e3309–e3327. <https://doi.org/10.1111/hsc.13910>

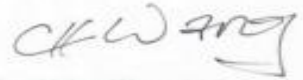
- Lodewijckx C, Sermeus W, Panella M, Deneckere S, Leigheb F, Troosters T, Boto PA, Mendes RV, Decramer M, Vanhaecht K. (2013). Quality indicators for in-hospital management of exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: results of an international Delphi study. *J Adv Nurs*. 69(2):348-62. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06013.x
- McPherson, S., Reese, C., & Wendler, M. C. (2018, Sep/Oct). Methodology Update: Delphi Studies. *Nurs Res*, 67(5), 404-410. <https://doi.org/10.1097/nnr>.
- Murray, J. W., & Hammons, J. O. (1995). Delphi: A Versatile Methodology for Conducting Qualitative Research. *The Review of Higher Education*, 18, 423. <https://doi.org/10.1353/rhe.1995.0008>
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017(6), CD000072. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>
- Rossetto, V., Toso, B. R. G. O., & Rodrigues, R. M. (2020). Organizational flow chart of home care for children with special health care needs. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(Suppl 4), e20190310. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0310>
- Rusli, K. D. B., Tan, A. J. Q., Ong, S. F., Speed, S., Lau, Y., & Liaw, S. Y. (2023). Home-based nursing care competencies: A scoping review. *Journal of Clinical Nursing*, 32(7–8), 1723–1737. <https://doi.org/10.1111/jocn.16169> s41366-018-0313-9
- Sangaleti, C., Schveitzer, M. C., Peduzzi, M., Zoboli, E. L. C. P., & Soares, C. B. (2017). Experiences and shared meaning of teamwork and interprofessional collaboration among health care professionals in primary health care settings: A systematic review. *JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, 15(11), 2723–2788.

<https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2016-003016>

- Stans, S. E. A., Stevens, J. G. A., & Beurskens, A. J. H. M. (2013). Interprofessional practice in primary care: Development of a tailored process model. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 6, 139–147. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S42594>
- Sterling, M. R., Dell, N., Piantella, B., Cho, J., Kaur, H., Tseng, E., Okeke, F., Brown, M., Leung, P. B. K., Silva, A. F., Shaw, A. L., & Kern, L. M. (2020). Understanding the workflow of home health care for patients with heart failure: Challenges and opportunities. *Journal of General Internal Medicine*, 35(6), 1721–1729. <https://doi.org/10.1007/s11606-020-05675-8> tb00055.x
- Van Vliet, D. C., van der Meij, E., Bouwsma, E. V., Vonk Noordegraaf, A., van den Heuvel, B., Meijerink, W. J., van Baal, W. M., Huirne, J. A., & Anema, J. R. (2016, Dec). A modified Delphi method toward multidisciplinary consensus on functional convalescence recommendations after abdominal surgery. *Surg Endosc*, 30(12), 5583–5595. <https://doi.org/10.1007/s00464-016-4931-9>
- Vogel, C., Zwolinsky, S., Griffiths, C., Hobbs, M., Henderson, E., & Wilkins, E. (2019, Dec). A Delphi study to build consensus on the definition and use of big data in obesity research. *Int J Obes (Lond)*, 43(12), 2573–2586. <https://doi.org/10.1038/>
- Wilkes, Lesley (2015). Using the Delphi technique in nursing research. *Nursing Standard*, 29(39), 43–49. doi:10.7748/ns.29.39.43.e8804
- World Health Organization(15 May 2013). WHO traditional medicine strategy: 2014-2023. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506096>
- Zwarenstein, M., Goldman, J., & Reeves, S. (2009). Interprofessional collaboration: effects of practice-based interventions on professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database Syst Rev*(3).<https://doi.org/10.1002/14651858>.

附錄

附錄一 研究倫理委員會研究計畫許可書

	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院研究倫理委員會 Research Ethics Committee Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation 707, Sec. 3, Chung-Yang Rd., Hualien, 97002, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-3-8561825 Ext. 12124 Fax: 886-3-8561825 Ext. 13272
研究計畫許可書	
本會編號：IRB112-209-B	
計畫名稱：以德菲法建構中西醫結合居家照護模式	
計畫主持人：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 六西病房 張瑋芬護理師	
計畫預計執行期間：自 September/30/2023 至 September/30/2024	
本許可書有效期間：自 November/07/2023 至 September/30/2024	
計畫文件版本日期：	
1. <u>計畫書(Protocol)</u> ：version 1，08/18/2023	
2. <u>中文摘要(Chinese Synopsis)</u> ：version 2，27/10/2023	
3. <u>受試者同意書(ICF)</u> ：version 2，24/10/2023	
4. <u>問卷(Questionnaire)</u> ：version 1，08/18/2023	
上述計畫業經本院研究倫理委員會於 2023 年 11 月 07 日審查同意，本委員會的運作符合優良臨床試驗準則及政府相關法律規章。	
計畫主持人須依國內相關法令及本會規定通報嚴重不良反應事件及非預期問題，並應於許可書到期日至少 6 週前提出期中追蹤審查申請，經本會審核通過，方可繼續執行。	
Certificate of Approval	
REC No.：IRB112-209-B	
Title of Protocol：Using Delphi Method to Construct the Home Care Model of Traditional Chinese and Western Medicine Collaboration	
Principal Investigator：Wei-Fen Chang / Department of Six West Ward, Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation	
Proposed Study Period：September/30/2023 to September/30/2024	
Approval Effective Period：November/07/2023 to September/30/2024	
The protocol is approved by the Research Ethics Committee of Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation on November/07/2023 . The committee is organized under, and operates in accordance with, the Good Clinical Practice guidelines and governmental laws and regulations. The investigator is required to report Serious Adverse Events and Unanticipated Problems in accordance with the governmental laws and regulations and REC of Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation requirements and apply for a continuing review not less than six weeks prior to the approval expiration date.	
	 Chien-Hsing Wang, M.D. Chairman, Research Ethics Committee
E6A0021538-10 Page 1 of 1	

附錄二 研究倫理委員會研究計畫變更許可書



佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院研究倫理委員會

Research Ethics Committee

Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

707, Sec. 3, Chung-Yang Rd., Hualien, 970, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-3-8561825 Ext. 12124 E-mail: irb@tzuchi.com.tw

研究計畫變更許可書

本會編號：IRB112-209-B

計畫名稱：以德菲法建構中西醫結合居家照護模式

計畫主持人：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 六西病房 張瑋芬護理師

計畫預計執行期間：自 September/30/2023 至 June/30/2025

本許可書有效期間：自 February/19/2025 至 February/28/2025

變更文件版本日期：

1. 計畫書(Protocol)：Version 3, 02/10/2025
2. 中文摘要(Chinese Synopsis)：Version 3, 02/10/2025
3. 受試者同意書(ICF)：Version 4, 12/02/2025
4. 計畫執行期限展延至 2025 年 06 月 30 日

上述計畫變更業經本院研究倫理委員會於 2025 年 02 月 19 日審查同意，本委員會的運作符合優良臨床試驗準則及政府相關法律規章。

計畫主持人須依國內相關法令及本會規定通報嚴重不良反應事件及非預期問題，並應於到期日至少 6 週前提出期中追蹤審查申請，經本會審核通過，方可繼續執行。

Certificate of Approval of Amendments

REC No. : IRB112-209-B

Title of Protocol : Using Delphi Method to Construct the Home Care Model of Traditional Chinese and Western Medicine Collaboration

Principal Investigator: Wei-Fen Chang / Department of Six West Ward, Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

Proposed Study Period : September/30/2023 to June/30/2025

Approval Effective Period : February/19/2025 to February/28/2025

The protocol is approved by the Research Ethics Committee of Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation on February/19/2025. The committee is organized under, and operates in accordance with, the Good Clinical Practice guidelines and governmental laws and regulations.

The investigator is required to report Serious Adverse Events and Unanticipated Problems in accordance with the governmental laws and regulations and REC of Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation requirements and apply for a continuing review not less than six weeks prior to the approval expiration date.



Chien-Hsing Wang, M.D.

Chairman, Research Ethics Committee

附錄三 學位論文原創性比對檢核表

20241106

國立臺北護理健康大學研究生學位論文原創性比對檢核表

研究生姓名	張瑋芬	學號	08111901
就讀系所	護理所	考試日期	114/07/24
論文中文題目	以德菲法建構中西醫居家照護模式		
論文英文題目	Development of A Home Care Model for Collaboration Between Traditional Chinese and Western Medicine Systems: A Delphi Method		
論文比對結果			
提交日期	114/08/29	提交物件代碼	2736025203
1. 經使用本校原創性論文比對系統檢核論文內容，比對結果之相似度指標為 <u>14</u> % (請填寫百分比)，並經指導(共同)教授檢視原創性比對報告內容確認沒有抄襲。檢附原創性比對報告書第一頁及最後一頁比對結果。			
研究生簽名：張瑋芬		日期：114年8月29日	
指導教授簽名：江瓊玲		日期：114年8月29日	
共同指導教授簽名：		日期： 年 月 日	

備註：若使用快刀中文相似度比對系統，僅需附上第一頁比對結果即可。

以德菲法建構中西醫居家照護模 式.pdf

作者為 張瑋芬

提交日期: 2025年08月29日 01:56下午 (UTC+0800)

作業提交代碼: 2736025203

文檔名稱: 以德菲法建構中西醫居家照護模式.pdf (2.09M)

文字總數: 24757

字符總數: 60152

以德菲法建構中西醫居家照護模式.pdf

原創性報告



主要來源

1	www.jct.org.tw	1%
2	www.nhi.gov.tw	1%
3	irlib.ntunhs.edu.tw	<1%
4	Submitted to China Medical University, Taiwan	<1%
5	www.mohw.gov.tw	<1%
6	zh.wikipedia.org	<1%